PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

UE B2 S1 · Support officiel 2026 et compléments du cours

Fondements | Bébé | Attachement | Enfance | Adolescence | Vieillissement | Pièges | Lexique

01 · Comprendre le développement tout au long de la vie

Repère : support de N. Khatir, p. 1, 2, 3. Explications et compléments oraux intégrés.

La psychologie du développement étudie la genèse et les transformations des conduites et des systèmes qui les structurent au cours de toute l'existence. Elle examine les changements liés à l'âge, leurs mécanismes et leur variabilité. La psychologie de l'enfant étudie plus spécifiquement les compétences et les performances psychologiques des enfants, avec notamment des applications à l'éducation. Leurs champs se recoupent sans être identiques.

Le développement concerne des dimensions interdépendantes : motricité, perception, cognition, langage, émotions, relations et identité. Une acquisition modifie les possibilités d'expérience : mieux contrôler sa posture facilite l'exploration visuelle et la préhension ; se déplacer transforme les relations spatiales ; parler permet de négocier une séparation. Aucune dimension ne se développe isolément.

L'opposition inné/acquis ne suffit pas. Le patrimoine génétique et la maturation biologique rendent certaines acquisitions possibles ; les expériences, les interactions et les conditions de vie les orientent. Le génotype est l'ensemble des caractéristiques génétiques ; le phénotype correspond aux caractéristiques observables issues de leur expression dans un environnement. L'épigenèse désigne ici la construction progressive du fonctionnement par ces interactions, sur les plans neurobiologique et psychologique.

La plasticité cérébrale désigne la capacité des réseaux nerveux à se modifier avec le développement et l'expérience. Elle éclaire l'intérêt de stimulations adaptées et d'un accompagnement précoce. Elle ne signifie ni que tout est possible à tout âge, ni qu'une difficulté témoigne nécessairement d'un défaut de stimulation.

> **Base de ce cours**
>
> Fiche personnelle complétée à partir du support officiel de N. Khatir (2026, 35 pages), confronté aux captures et aux transcriptions déjà examinées. Les explications utiles de l'oral sont conservées. Les âges situent des acquisitions ou des modèles ; ils ne sont pas des seuils diagnostiques. Cette synthèse ne constitue pas le document officiel de l'enseignante.

Repères historiques du support (p. 3) : l'évolutionnisme de Lamarck et Darwin, puis la génétique, déplacent le débat inné/acquis. Mendel est associé à la ségrégation des allèles, à l'assortiment indépendant et à la dominance ; les travaux de Morgan relient les gènes aux chromosomes. Ces notions n'impliquent pas que tous les caractères suivent une transmission simple : la dominance n'est pas universelle et des gènes liés ne s'assortissent pas indépendamment. L'enjeu du chapitre reste l'interaction entre dispositions et environnement.

02 · Normal, pathologique et variations du développement

Repère : support de N. Khatir, p. 4. Explications et compléments oraux intégrés.

Le normal possède plusieurs sens : ce qui est fréquent statistiquement, ce qui correspond aux normes sociales, ce qui est considéré comme idéal, ou l'absence de maladie. Ces sens ne sont pas interchangeables. Une caractéristique rare, une différence culturelle ou un décalage isolé ne constituent pas, à eux seuls, une pathologie.

Le pathologique peut être défini par la maladie et ses mécanismes, par une désignation professionnelle, par des normes culturelles ou par le retentissement pratique. Le cours présente aussi une approche centrée sur l'ajustement entre la personne et son environnement : des aménagements peuvent réduire les limitations sans faire disparaître une affection.

La question de la continuité ou de la discontinuité oppose des conceptions en continuum et des conceptions distinguant des organisations qualitativement différentes. Dans l'observation, croiser la trajectoire, les compétences dans plusieurs domaines, le contexte, la souffrance et le retentissement. Un âge moyen ne constitue pas un seuil diagnostique.

Une perte d'acquis, une stagnation importante ou des difficultés persistantes justifient un avis professionnel. Observer et transmettre des faits précis : ce que l'enfant faisait auparavant, ce qu'il fait aujourd'hui, dans quelles situations, avec quelles aides. Le repérage prépare une évaluation ; il ne remplace pas le diagnostic.

Lecture du pathologique	Sens présenté dans le support et limite
Statistique	Écart ou rareté dans une population ; une rareté ne suffit pas à établir une maladie.
Professionnelle	Désignation par un professionnel (médecin, psychologue…). Elle repose sur une appréciation clinique située.
Sociale	Écart à ce qu'une culture considère comme normal ; les normes dépendent du contexte.
Existentialiste	Le support privilégie ici la modification de l'environnement plutôt que celle de l'individu : interroger les conditions de vie et les possibilités d'ajustement.
Pratique	Trois critères cités : inconfort, bizarrerie, inefficacité. Ils doivent être contextualisés ; une conduite inhabituelle n'est pas automatiquement pathologique.

Le normal comme idéal renvoie à ce qui est souhaité ou valorisé ; le normal comme absence de maladie renvoie à un état de santé sans affection identifiée. La prévalence décrit les cas existants dans une population à un moment ou sur une période ; l'incidence concerne les nouveaux cas apparus pendant une période. L'étiologie étudie les causes d'une maladie ; la pathogénie, les mécanismes de son développement. Ces termes ne sont pas interchangeables [R11].

03 · Devenir parent : trois désirs à distinguer

Repère : support de N. Khatir, p. 5. Explications et compléments oraux intégrés.

Dans la lecture psychodynamique présentée, le désir de grossesse est le désir de vivre l'état de grossesse, les transformations corporelles ou un sentiment de complétude. Il peut aussi mettre en jeu la fécondité, l'image du corps et la relation au partenaire. Il ne garantit pas que la personne se sente prête à accueillir un enfant dans sa singularité.

Le projet d'enfant est une démarche consciente inscrite dans un projet de vie : organisation, couple, idéaux et attentes familiales ou sociales. Programmer une conception ne permet pas de maîtriser entièrement la rencontre avec l'enfant. Un projet très préparé n'assure pas une parentalité sans difficulté ; une grossesse imprévue peut être bien accueillie.

Le désir d'enfant comporte des composantes conscientes et inconscientes, liées notamment à l'histoire personnelle et aux identifications aux figures parentales. Les attentes transgénérationnelles peuvent soutenir l'enfant ou lui assigner une mission trop lourde : réparer une perte, réaliser les ambitions parentales ou combler toutes les attentes affectives de l'adulte.

L'enfant imaginaire est l'enfant investi dans les représentations, les souhaits et les projections parentales. L'enfant réel est celui que les parents rencontrent, avec ses caractéristiques et ses besoins propres. Le deuil de l'enfant imaginaire désigne le remaniement de ces attentes pour reconnaître et accueillir l'enfant réel. Ce travail ne signifie pas l'absence d'amour et peut demander un accompagnement.

Ces modèles aident à explorer une expérience singulière. Ils ne permettent pas de déduire la personnalité d'une personne de son désir ou de son absence de désir d'enfant. Pour le soin, écouter sans imposer un idéal familial ni culpabiliser.

04 · Grossesse : remaniements psychiques et premières relations

Repère : support de N. Khatir, p. 6. Explications et compléments oraux intégrés.

Le cours décrit un itinéraire possible, qui reste singulier. Au début, l'attention peut être centrée sur le corps, ses changements et des affects mêlant fierté, anxiété et étrangeté. Certains auteurs parlent d'un « blanc d'enfant » : être enceinte ne signifie pas encore pouvoir se représenter précisément un bébé. La première échographie peut contribuer à organiser ces représentations.

Au deuxième trimestre, les mouvements perçus rendent la présence du bébé plus tangible et enrichissent les représentations. Au troisième trimestre, l'approche de la naissance peut associer excitation, inquiétude et préparation à rencontrer l'enfant réel. Il ne s'agit pas de trois états obligatoires ni d'un calendrier de la bonne maternité.

Winnicott nomme préoccupation maternelle primaire un état de sensibilité particulière aux besoins et aux signaux du bébé, situé en fin de grossesse et dans les semaines suivant la naissance. Ce concept théorique décrit une disponibilité très ajustée ; son vocabulaire historique ne fait pas de la mère biologique l'unique adulte capable de prendre soin.

La paternité ou l'accès à une fonction parentale demandent aussi des remaniements et des identifications. La couvade psychosomatique désigne des manifestations corporelles rapportées chez certains futurs pères durant la grossesse de leur partenaire, par exemple des troubles digestifs ou une prise de poids. Ce n'est ni un passage obligatoire ni une explication à tout symptôme somatique.

> **Pour accompagner**
>
> Accueillir l'ambivalence, explorer les représentations et les soutiens disponibles. Une souffrance marquée demande une évaluation. Ne pas expliquer une complication obstétricale par un conflit psychique supposé.

05 · Compétences fœtales : une sensorialité progressive

Repère : support de N. Khatir, p. 7. Explications et compléments oraux intégrés.

Le développement commence avant la naissance. Le cours retient une mise en fonction progressive des systèmes sensoriels : toucher, sensibilité à l'équilibre, olfaction-gustation, audition, puis vision. Cette séquence est un repère d'organisation ; la maturation de chaque système se poursuit et ne se résume pas à une date unique.

Les contacts corporels et les mouvements participent aux premières expériences. Des saveurs passent dans le liquide amniotique ; l'environnement sonore comprend notamment les bruits corporels et des sons extérieurs atténués. La voix maternelle est accessible par plusieurs voies de transmission. La vision reste beaucoup moins sollicitée dans l'environnement utérin.

Les préférences et reconnaissances observées après la naissance, notamment pour des voix, des rythmes de langue ou des odeurs familières, témoignent de capacités d'apprentissage prénatal. Elles ne constituent pas un lien d'attachement déjà entièrement organisé et ne réservent pas l'attachement à une seule personne.

La période embryonnaire correspond principalement à la mise en place des structures ; la période fœtale à leur croissance et à leur maturation. L'existence de compétences sensorielles précoces ne signifie pas que tous les systèmes possèdent déjà le fonctionnement d'un adulte.

06 · Développement postural, moteur et autonomie

Repère : support de N. Khatir, p. 8, 9. Explications et compléments oraux intégrés.

Le nouveau-né humain présente une grande immaturité et une dépendance prolongée, décrites dans le cours par le terme de néoténie. Ses mouvements sont d'abord globaux ; le tonus et le contrôle des segments corporels se transforment. Les réflexes archaïques, comme la succion, l'agrippement ou le réflexe de Moro, font partie de l'examen neurologique précoce.

Deux directions organisent la progression : céphalo-caudale, de la tête vers le bas du corps, et proximo-distale, de l'axe du corps vers les extrémités. Le contrôle de la tête et du tronc rend progressivement possibles l'assise, les déplacements et une motricité manuelle plus précise.

Les âges ci-dessous reprennent les repères de la séance. Ils ne sont ni des obligations ni des seuils de diagnostic. La qualité du mouvement, la progression et les différences entre domaines comptent aussi. Le passage par le quatre-pattes n'est pas universel : son absence isolée ne permet pas de conclure à un trouble intellectuel ou neurologique [R1].

Acquisition	Repères du cours et progression
Préhension	Vers 4 mois : coordination visuo-manuelle. Puis prise palmaire avec les trois derniers doigts, prise en râteau, enfin pince pouce-index vers 9 mois. La précision augmente les possibilités d'exploration.
Tête et assise	Vers 2-3 mois : tête davantage tenue dans l'axe ; vers 4-5 mois : soulèvement tête-épaules ; vers 6 mois : dos plus droit ; vers 7-9 mois : assise plus stable et possibilité de s'asseoir.
Déplacements et marche	Retournements, déplacements au sol, mise debout avec puis sans appui. La séance situe le quatre-pattes autour de 8-10 mois et la marche autour de 12-15 mois, avec une variabilité importante. Une difficulté persistante nécessite une évaluation.

Acquisition	Repères du cours et progression
Vers 18 mois-2 ans	Marche plus assurée, escaliers avec aide puis davantage d'autonomie, course, lancer de balle, participation à l'habillage. Motricité fine : gribouiller, enfiler de grosses perles adaptées, tourner les pages, empiler des cubes.
Vers 3 ans	Meilleure coordination main-doigts, cercles, forme dessinée et nommée, sauts pieds joints, tricycle selon les expériences. Le retentissement d'une difficulté compte davantage qu'un geste isolé.

Continence : rectifier les seuils

L'acquisition dépend de la maturation, de la perception des sensations, des possibilités de communication et du contexte. La marche ne prouve pas à elle seule la maturité sphinctérienne. Les repères diurnes et nocturnes varient. Pour l'énurésie nocturne, le seuil usuel est 5 ans ; pour l'encoprésie, 4 ans : le seuil oral unique de 4 ans pour les deux est à corriger [R2-R3].

07 · Le bébé perçoit, discrimine et anticipe

Repère : support de N. Khatir, p. 10. Explications et compléments oraux intégrés.

La discrimination permet de différencier des stimuli : voix, visages ou expressions émotionnelles. La catégorisation regroupe des éléments partageant des caractéristiques. Ces compétences apparaissent progressivement et se raffinent ; leur mesure dépend de la tâche utilisée.

La coordination intersensorielle relie plusieurs modalités sensorielles : associer ce qui est vu à ce qui est touché, par exemple. Le bébé ne reçoit donc pas seulement des sensations séparées ; il apprend à articuler ses expériences pour reconnaître et anticiper.

La permanence de l'objet est la compréhension qu'un objet continue à exister hors de la perception immédiate. Elle se construit par étapes. Anticiper visuellement la sortie d'un objet derrière un écran ne signifie pas encore pouvoir le rechercher par une action complexe ou reconstituer tous ses déplacements.

Dans l'erreur A-non-B décrite par Piaget, l'enfant peut continuer à chercher un objet à l'emplacement A où il l'a retrouvé plusieurs fois, alors qu'il l'a vu être caché en B. La conduite de recherche mobilise plusieurs capacités : représentation, mémoire, contrôle de l'action. Ne pas assimiler une réussite précoce de regard à la maîtrise de toutes ces conduites.

Les réactions de surprise devant certains événements impossibles et les explorations répétées des objets éclairent des attentes précoces concernant la gravité, les trajectoires ou la matière. Jeter un objet et observer sa chute peut être une exploration. Sécuriser la situation et proposer des objets adaptés.

La permanence cognitive d'un objet et la sécurité affective dans une séparation sont liées dans l'expérience, mais restent deux notions distinctes. Une difficulté de séparation ne prouve pas une absence de permanence de l'objet et ne permet pas de diagnostiquer une psychose.

08 · Piaget : comment l'action devient connaissance

Repère : support de N. Khatir, p. 11, 12. Explications et compléments oraux intégrés.

Un schème est une organisation d'action ou de pensée réutilisable dans des situations comparables : saisir, regarder, classer, comparer. L'adaptation est l'ajustement des conduites aux rapports entre l'organisme et son milieu. Elle associe assimilation et accommodation.

L'assimilation intègre une expérience nouvelle dans un schème déjà disponible : saisir un nouveau hochet avec une prise connue. L'accommodation transforme le schème pour traiter une situation nouvelle : modifier sa prise pour réussir à saisir un objet autrement. L'équilibration désigne les réorganisations qui restaurent une cohérence entre les connaissances et les situations rencontrées.

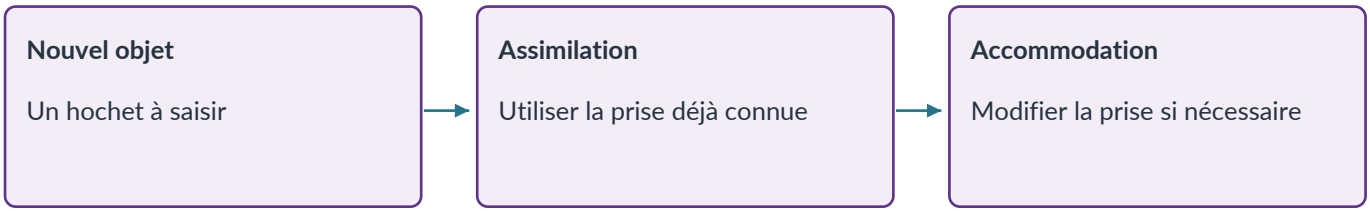
L'intelligence sensori-motrice, jusqu'à environ 2 ans, se construit à partir de la perception et de l'action avant que les représentations deviennent centrales. Le passage à une conduite intentionnelle implique de distinguer un moyen et un but. Les réactions circulaires consistent à reproduire une action découverte fortuitement parce que son résultat intéresse l'enfant.

Sous-stade	Conduites à comprendre
I · Premier mois	Exercice des réflexes, puis ajustement progressif des actions ; débuts de l'assimilation et de l'accommodation.
II · Vers 1-4 mois	Réactions circulaires primaires : répétition centrée sur le corps propre, par exemple reproduire une vocalisation. Le support dit 2-4 mois ; la frontière est un repère du modèle.
III · Vers 4-8/9 mois	Réactions circulaires secondaires centrées sur les objets ; coordination vision-préhension, reproduction d'un effet intéressant, par exemple agiter un hochet.
IV · Vers 8/9-12 mois	Coordination de schèmes secondaires dans une situation nouvelle, anticipation, distinction moyen-but et liens de causalité. Exemple : déplacer un obstacle pour accéder à un objet.
V · Vers 12-18 mois	Réactions circulaires tertiaires : faire varier les actions pour expérimenter des effets ; conduites du support, de la ficelle ou du bâton pour rapprocher un objet.
VI · Vers 18-24 mois	Combinaisons mentales et nouveaux moyens conçus avant l'action ; insight, imitation différée et développement des représentations de l'objet, de l'espace, du temps et de la causalité.

Trois réactions circulaires

Primaire : mon corps. Secondaire : un effet produit sur un objet. Tertiaire : je varie mon action pour explorer de nouveaux effets. Les âges servent à situer la progression théorique, sans enfermer un enfant dans une case.

Assimiler une situation ou transformer son schème



L'expérience modifie les connaissances ; assimilation et accommodation se complètent.

Les deux processus participent à l'adaptation. La figure compare leurs fonctions ; elle ne les réduit pas à deux étapes toujours successives.

09 · De la perception du langage aux premiers énoncés

Repère : support de N. Khatir, p. 13. Explications et compléments oraux intégrés.

La compréhension et la perception du langage se développent avant sa production maîtrisée. Le nourrisson distingue des sons et se montre sensible à la prosodie, c'est-à-dire au rythme, à l'accentuation et aux variations d'intonation. Les capacités de discrimination se spécialisent progressivement selon les langues entendues.

Les valeurs de vocabulaire ci-dessous sont des ordres de grandeur donnés dans le cours, très variables selon les enfants et les conditions d'observation. Toujours distinguer mots compris et mots produits. Un mot reconnu dans une situation familière n'est pas nécessairement compris hors contexte.

Période	Compréhension / perception	Production / communication
0-5 mois	0-1 mois : distinction de sons proches et sensibilité à la prosodie et aux voix familières. Vers 5 mois : reconnaissance d'une syllabe dans différents contextes et catégorisation des sons.	Cris, sons végétatifs, vocalisations ; sourire social et échanges d'intonations progressivement ajustés.
6-10 mois	Spécialisation perceptive selon les langues ; repérage progressif de groupes de mots et de leurs frontières.	Vers 5-7 mois : imitation des intonations ; vers 7 mois : babillage consonne-voyelle. Vers 8-10 mois : les productions prennent les caractéristiques des langues de l'entourage.
11-12 mois	Le cours évoque environ 30 mots compris en contexte et quelques mots très familiers hors contexte.	Des formes sonores sont associées de façon plus stable à des situations. Les adultes y reconnaissent progressivement des mots.
12-16/18 mois	Environ 100-150 mots compris et débuts de compréhension de phrases, selon la séance.	Le support situe les 50 premiers mots vers 12-16/18 mois, avec une intonation ressemblant à des phrases ; styles référentiel et expressif (K. Nelson, 1985). Repères variables, sans minimum clinique obligatoire.
16-20 mois	Le cours évoque environ 200 mots compris et une catégorisation plus précise : actions, objets animés ou non.	Diversification du vocabulaire et des fonctions communicatives. Le geste et le contexte soutiennent le sens.

Période	Compréhension / perception	Production / communication
18-24 mois	Compréhension croissante des relations entre mots et de leur ordre syntaxique.	Le cours évoque 200-300 mots vers la fin de cette période, premières associations de 2-3 mots, mots pivots et style télégraphique. Ce n'est pas un minimum clinique obligatoire.

Deux styles et un geste essentiel

Le style référentiel privilégie les noms ; le style expressif utilise davantage des expressions ou fragments de phrases. Aucune voie n'est supérieure. Le pointage, souvent accompagné d'un regard ou d'un son, permet de demander ou de partager un intérêt. Son absence persistante s'évalue dans un ensemble de signes ; elle ne suffit pas à diagnostiquer un autisme [R4].

Au début, un mot peut valoir un énoncé entier : « gâteau » signifie selon le contexte « je veux un gâteau » ou « voici un gâteau ». On parle de mot-phrase ou holophrase. Dans les premières combinaisons, un mot pivot revient dans plusieurs énoncés : « encore gâteau », « encore eau ». Le style télégraphique conserve les mots porteurs du sens et omet souvent certains mots grammaticaux.

L'ordre des mots peut modifier le sens : « Pierre tape Paul » n'exprime pas la même action que « Paul tape Pierre ». Le cours situe la compréhension croissante de ces relations vers 21-24 mois ; les indices pertinents varient selon les langues. Il situe le pointage vers 10-13 mois, comme repère approximatif et non comme seuil diagnostique isolé.

Le cours évoque les hésitations et répétitions de parole à 2-3 ans. Toutes ne correspondent pas à un trouble durable, mais il ne faut pas affirmer qu'un bégaiement est toujours « physiologique » et disparaîtra seul. Des blocages, une gêne ou une inquiétude justifient d'en parler et de demander un avis sans attendre [R10].

10 · Premières interactions et langue adaptée à l'enfant

Repère : support de N. Khatir, p. 14. Explications et compléments oraux intégrés.

Le bébé est un partenaire actif : regard, expressions, mouvements, vocalisations et détournement du regard peuvent ouvrir, prolonger ou interrompre un échange. L'adulte s'ajuste aux signaux et aux rythmes. Le tour de rôle, proche d'une alternance de parole, se construit précocement : le bébé vocalise, l'adulte répond, puis laisse une place à sa réponse.

L'attention conjointe est le partage d'attention avec une autre personne à propos d'un objet ou d'un événement. Des formes de soutien de l'attention apparaissent tôt ; le partage intentionnel et le pointage se développent ensuite. Regarder le même jouet ne suffit pas toujours : l'enjeu est aussi de partager l'intérêt avec l'autre.

L'adulte étaye l'exploration : il rend un objet accessible, attire l'attention sur une caractéristique, ajuste l'aide et reconnaît la réussite. Proposer un environnement lisible et des sollicitations adaptées aide l'enfant à s'engager. Cela ne permet pas d'affirmer qu'un excès de jouets cause un TDAH.

La langue adaptée à l'enfant (LAE), aussi appelée motherese ou mamané dans le cours, associe généralement une parole ralentie, une intonation accentuée, un vocabulaire concret, des énoncés courts, une syntaxe correcte et des répétitions. Elle facilite les échanges, la compréhension et l'acquisition du langage. Il s'agit de phrases adaptées, pas d'un langage volontairement incorrect.

Dans les soins, nommer ce que l'on fait, décrire les sensations et l'environnement, chanter et laisser des temps de réponse. Les partenaires se diversifient selon l'histoire familiale : parents, proches, fratrie et pairs. Les jeux d'offrande, d'imitation ou d'inversion des rôles soutiennent la réciprocité. Prendre le jouet d'un autre chez le

tout-petit ne se lit pas automatiquement comme un vol intentionnel.

Les repères oraux précisent des vocalisations fréquentes vers 2 mois et une alternance de type tour de parole vers 3-4 mois, soutenue par l'ajustement de l'adulte. Vers 5 mois, celui-ci peut déjà aider le bébé à maintenir son attention sur un objet. Ce soutien précoce ne se confond pas avec la coordination intentionnelle du regard entre personne et objet, développée plus tard.

Bruner décrit l'étayage dans l'activité partagée : mobiliser l'enfant vers un but, réduire la difficulté, signaler les caractéristiques pertinentes et évaluer ses productions. Le support situe un soutien de l'attention vers 5-6 mois et une inversion des rôles dans les échanges verbaux et gestuels vers 8-10 mois. Ces formes précoces se distinguent d'une attention conjointe intentionnelle pleinement coordonnée. La LAE comporte aussi souvent une voix plus aiguë ; les proches autres que la mère peuvent l'utiliser.

11 · Attachement : carences, séparations et éthologie

Repère : support de N. Khatir, p. 15, 16. Explications et compléments oraux intégrés.

La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby, s'intéresse au lien entre l'enfant et les personnes qui prennent soin de lui. La recherche de proximité a une fonction de protection et de sécurité. Ses origines croisent les observations de séparations et de carences, l'éthologie, la psychanalyse et d'autres approches du développement.

René Spitz décrit la carence affective comme un manque relationnel entravant le développement. Dans ses observations historiques, la dépression anaclitique apparaît après la séparation d'avec une figure auparavant investie : pleurs, retrait, troubles du sommeil et de l'alimentation, ralentissement ou régression du développement. La restauration d'une relation stable peut permettre une amélioration.

L'hospitalisme désigne les effets graves d'une privation relationnelle prolongée dans des conditions institutionnelles défaillantes : retrait massif, appauvrissement des interactions et du développement, manifestations somatiques et stéréotypies. Il ne signifie pas que toute hospitalisation provoque ce tableau. Les descriptions anciennes ne permettent pas d'assimiler carence affective et autisme.

Les Robertson décrivent trois phases possibles d'une séparation prolongée : protestation active, désespoir avec retrait, puis détachement apparent. Le retour d'une activité ne suffit donc pas toujours à prouver le bien-être. Ce modèle historique n'est ni une séquence obligatoire ni une façon de classer tout enfant qui ne pleure pas.

Les trois organisateurs de Spitz évoqués dans le cours sont le sourire social, l'angoisse dite du huitième mois et le « non ». Ce sont des repères de son modèle. Ils ne constituent pas à eux seuls un bilan de développement.

Travaux	Ce qu'ils apportent et leur limite
Lorenz · empreinte	Chez certaines espèces, une tendance précoce à suivre un stimulus mobile s'oriente vers l'objet rencontré dans une période sensible. L'objet est appris. Ne pas transposer directement cette situation aux liens humains.
Harlow · macaques rhésus	La préférence pour un substitut doux plutôt que pour le seul dispositif nourricier souligne la fonction du contact et du réconfort. La sécurité favorise aussi l'exploration. Ces expériences animales ne définissent pas à elles seules les besoins de tous les bébés humains.
Observations humaines	La qualité et la continuité des relations comptent au-delà des seuls soins alimentaires. Une figure de substitution stable peut apporter de la sécurité. Préserver les liens et individualiser les soins.

Précisions historiques de Spitz (support, p. 15) : la dépression anaclitique est décrite après la séparation de nourrissons de 6-8 mois auparavant pris en charge de façon privilégiée par leur mère. La séquence associe

d'abord cris et pleurs, puis retrait, fuite du contact, troubles du sommeil et de l'alimentation avec perte de poids, fragilité somatique et baisse ou régression du développement. Le retour de la figure ou un substitut de qualité peut améliorer le tableau. L'hospitalisme est décrit chez des bébés de 3-6 mois exposés à une privation durable sans substitut de qualité dans une institution défaillante. Ces âges situent les observations historiques ; ils ne limitent pas les âges où une privation relationnelle peut être nocive.

12 · Winnicott : porter, soigner et ouvrir au monde

Repère : support de N. Khatir, p. 16. Explications et compléments oraux intégrés.

Les soins primaires sont à la fois corporels et psychiques. Dans le modèle de Winnicott, leur qualité soutient l'intégration du bébé, l'appropriation du corps et la continuité du sentiment d'exister. Le self renvoie à cette expérience d'être soi ; il n'est pas simplement un synonyme de performance ou d'estime de soi.

Le holding désigne le portage et la contenance, physiques et psychiques : soutenir le corps, protéger d'excitations excessives, maintenir un environnement suffisamment fiable et garder une place à l'enfant dans l'attention de l'adulte. Le handling désigne la manière de le manipuler et de lui prodiguer les soins, en respectant ses rythmes et ses réactions. Il participe à l'articulation psyché-soma.

L'object-presenting est la présentation d'objets et, plus largement, la façon d'introduire progressivement le monde extérieur dans la relation. L'adulte ajuste la nouveauté et favorise une ouverture au-delà de la relation duelle.

L'objet transitionnel est un objet investi par l'enfant dans une aire intermédiaire entre vécu subjectif et réalité extérieure. Il peut aider à supporter l'absence. Les phénomènes transitionnels ne se limitent pas à une peluche : une mélodie ou un rituel peuvent remplir cette fonction. Un objet acheté comme « doudou » n'est pas automatiquement un objet transitionnel pour cet enfant.

> **Application au soin**
>
> Porter et installer avec attention, prévenir avant de toucher, ajuster le rythme, conserver des repères familiers et permettre l'usage du doudou habituel lorsque les conditions de soin le permettent. Ces concepts éclairent la relation sans remplacer l'évaluation somatique.

13 · Attachement : concepts et équilibre proximité-exploration

Repère : support de N. Khatir, p. 17. Explications et compléments oraux intégrés.

L'attachement est un lien affectif durable orienté vers une ou quelques figures privilégiées, recherchées comme source de sécurité en situation de détresse. Bowlby le considère comme un besoin social primaire : il ne découle pas seulement de la satisfaction alimentaire. Le besoin de relation possède des bases précoces ; le choix des figures se construit dans l'expérience.

Les comportements d'attachement sont les conduites qui favorisent la proximité : sourires et vocalisations, cris et pleurs, agrippement, poursuite, puis langage et autres moyens de contact. Il faut distinguer le lien durable et les manifestations observables à un moment donné.

La figure d'attachement est la personne vers laquelle ces conduites sont orientées. Elle s'engage de façon régulière dans des interactions vivantes et répond aux signaux de l'enfant. Elle peut être la mère, le père ou un autre adulte familier. La sensibilité consiste à percevoir et comprendre les signaux ; la responsivité renvoie à une réponse ajustée.

Le caregiver est la personne qui prend soin ; le caregiving est le système complémentaire de protection et de réconfort. Il vise à rétablir une sécurité physique et psychique lorsque l'enfant ou une autre personne est en difficulté. Présence physique et disponibilité psychique ne se confondent pas.

La base de sécurité repose sur la confiance dans la disponibilité d'une figure vers laquelle revenir. Elle rend possible l'exploration : l'enfant s'éloigne quand il se sent suffisamment sûr, puis recherche du réconfort en cas d'alarme. La distance optimale dépend de l'âge, du contexte et du besoin. Sécuriser ne signifie pas empêcher toute séparation.

Une émotion est une réaction généralement assez brève à une situation significative pour le sujet, associant expérience subjective, évaluation cognitive et modifications corporelles. Le cours reprend six émotions de base selon Ekman : joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise. Cette liste appartient à un modèle de classification.

La peur et l'angoisse peuvent activer la recherche de protection ; la colère accompagner une rupture du lien ; la tristesse, l'indisponibilité ressentie ; la joie, les retrouvailles et le réconfort. Une émotion désagréable a aussi une fonction adaptative. Distinguer l'émotion, qui peut être accueillie, et le comportement, qui peut nécessiter une limite.

Pour analyser un texte, distinguer trois familles de comportements (p. 17) : signaux d'interaction (sourire, vocalisations), signaux aversifs (cris, pleurs) qui attirent le proche, et conduites actives (agrippement, poursuite) qui réduisent la distance. Des moyens acquis, dont le langage, remplissent ensuite cette fonction. Le caregiving s'accompagne aussi d'émotions chez le caregiver : plaisir, satisfaction ou soulagement lorsqu'il peut protéger ; colère, tristesse ou anxiété lorsqu'il ne le peut pas. Ce sont des dimensions du modèle, pas une évaluation morale du parent.

De l'alarme à la reprise de l'exploration

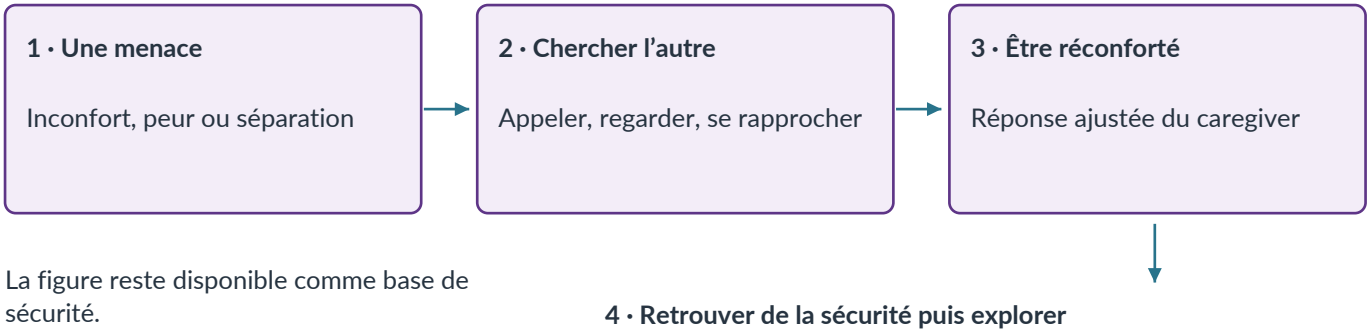


Schéma fonctionnel : une réponse sécurisante facilite l'exploration. L'enfant peut revenir chercher du réconfort lorsque son besoin change.

14 · Construction de l'attachement et modèles internes opérants

Repère : support de N. Khatir, p. 18, 25. Explications et compléments oraux intégrés.

Le cours distingue les signaux précoces et l'organisation progressive d'un attachement sélectif. Dès la naissance, le bébé recherche des interactions et reconnaît certaines caractéristiques familières ; cela ne signifie pas qu'un lien sélectif complet soit formé en quelques jours.

Les modèles internes opérants (MIO) sont des représentations de soi, d'autrui et des interactions, construites à partir des expériences. Ils permettent d'anticiper les réactions des proches et d'orienter les conduites. Le bébé fait progressivement l'expérience d'être digne d'attention, et de l'autre comme disponible ou peu accessible. Au départ surtout sensori-motrices, ces représentations s'enrichissent avec le langage.

Ces modèles ne sont pas un destin figé. Ils peuvent se modifier avec de nouvelles relations et les changements de conditions de vie. Une attitude méfiante peut se comprendre dans une histoire relationnelle ; elle ne doit pas être immédiatement interprétée comme un rejet personnel du soignant.

Période du modèle	Organisation du lien
0-3 mois	Orientation et signaux peu sélectifs, interactions avec les adultes disponibles. Reconnaissances précoces possibles, sans attachement pleinement différencié.
3-6 mois	Orientation préférentielle vers des figures familières, différenciation progressive de l'étranger, premiers MIO.
6 mois-3e année	Maintien actif de la proximité par les signaux puis la locomotion ; base de sécurité, réactions de séparation et peur de l'étranger ; le langage enrichit les moyens de contact.
Vers 2½-4 ans	Partenariat émergent corrigé quant au but : l'enfant prend davantage en compte les intentions de l'autre ; on peut expliquer et organiser les modalités de séparation et de retour.
4-12 ans	Les systèmes exploratoire et affiliatif deviennent plus visibles ; figures auxiliaires possibles. Un modèle plus général des relations se construit. Le besoin d'attachement demeure.

15 · La situation étrange et les formes d'attachement

Repère : support de N. Khatir, p. 19. Explications et compléments oraux intégrés.

La situation étrange de Mary Ainsworth est une procédure d'observation standardisée, classiquement auprès d'enfants de 12-18 mois avec une figure d'attachement. Huit épisodes brefs incluent présence, départ, retour et intervention d'une personne non familière. L'analyse porte notamment sur les retrouvailles et la possibilité d'utiliser la figure comme source de réconfort.

Trois profils initiaux sont distingués ; une catégorie désorganisée est ensuite développée notamment par Mary Main et Judith Solomon. Les catégories décrivent des organisations relationnelles observées dans des conditions précises. Elles ne sont pas des diagnostics psychiatriques ni des étiquettes définitives de la personnalité.

Profil	Organisation des conduites et retrouvailles
Sécure	L'enfant peut protester à la séparation. Il recherche ou accueille le contact au retour, peut être réconforté puis reprendre l'exploration. La sécurité ne se mesure pas à l'absence de pleurs.
Insécure évitant	Les manifestations visibles de détresse et la recherche de proximité sont limitées ; l'enfant peut éviter le contact au retour et se centrer sur les objets. Peu montrer sa détresse ne signifie pas ne rien éprouver.
Insécure ambivalent / résistant	Détresse à la séparation, recherche de contact associée à de la résistance ou de la colère au retour ; réconfort difficile, exploration entravée.
Désorganisé	Conduites contradictoires, interrompues ou figées, sans stratégie cohérente à certains moments. La figure peut être à la fois recherchée pour le réconfort et associée à l'alarme. Cela ne prouve pas à soi seul une maltraitance.

Interpréter avec prudence

Tenir compte du tempérament, des expériences antérieures, de la relation spécifique et de la culture. Un enfant calme à la crèche, un adolescent réservé ou une séparation difficile ne suffisent pas à attribuer un profil. Les organisations d'attachement peuvent évoluer.

16 · Séparations, maladie, deuil, adoption et placement

Repère : support de N. Khatir, p. 20. Explications et compléments oraux intégrés.

Un mode de garde non parental s'apprécie selon sa qualité, la stabilité des adultes, la prévisibilité des transitions, les besoins de l'enfant et l'ensemble de son environnement. Le cours exprime une préférence pour des séparations initiales tardives et des journées courtes ; il ne faut pas en faire un seuil universel de danger avant un âge donné. Un accueil de qualité peut aussi apporter un appui quand le milieu familial est en difficulté.

Lors d'une séparation parentale, l'enjeu est de préserver une alliance de caregiving : transmettre les informations utiles, organiser les passages et éviter que l'enfant porte le conflit. Le divorce ne provoque pas automatiquement un trouble de l'attachement. Les modalités d'hébergement doivent être appréciées selon l'âge, les liens existants, les besoins et la situation réelle.

La maladie, la douleur, la fatigue, les soins invasifs et les personnes inconnues peuvent activer le système d'attachement. En pédiatrie, favoriser la présence des proches, la continuité des soignants, les explications adaptées, les repères familiers et une alliance avec les parents. Ne pas réduire les pleurs à un caprice ; rechercher aussi douleur, inconfort ou besoin somatique.

Quand un handicap rend les signaux plus discrets ou difficiles à lire, aider les proches à repérer les manifestations propres à cet enfant. Soutenir leur sensibilité et leur capacité de réponse, sans conclure que tous les enfants porteurs du même handicap communiquent de façon identique.

Lors d'un deuil, expliquer avec des mots concrets et adaptés que la personne est morte et ne reviendra pas, accueillir les questions et préciser que l'enfant n'en est pas responsable. Éviter des formulations ambiguës comme « il dort » ou « il est parti » utilisées seules. Les réponses et le rythme dépendent de l'âge et de l'histoire du lien.

L'adoption et le placement peuvent associer pertes, ruptures et création de nouveaux liens. Certains enfants expriment méfiance, retrait, agressivité ou sociabilité indiscriminée. Cette dernière correspond à une approche peu différenciée des adultes, parfois trop familière, avec peu de vérification auprès d'un adulte repère. Ce n'est pas synonyme d'un attachement sécure avec tout le monde.

Un accueil bienveillant ne répare pas instantanément les expériences antérieures. Prévoir stabilité, accompagnement et soins lorsqu'ils sont nécessaires ; soutenir les adultes accueillants et travailler les liens avec l'histoire familiale sans disqualifier les origines.

17 · De 2-3 à 12 ans : langage, symboles, dessin et lecture

Repère : support de N. Khatir, p. 21. Explications et compléments oraux intégrés.

La fonction sémiotique permet d'évoquer un objet, une personne ou un événement au moyen de signes ou de symboles, notamment en leur absence : langage, gestes symboliques, imitation différée, jeu de faire-semblant, dessin et images mentales. Représenter n'est plus seulement agir en présence de l'objet.

Le lexique s'enrichit : noms, verbes et mots grammaticaux. La sous-extension limite un mot à une partie trop étroite de sa catégorie, par exemple « chien » pour le seul caniche familial. La sur-extension l'étend trop largement, par exemple « chat » pour tout animal à quatre pattes. Les catégories se précisent avec l'expérience.

La syntaxe organise les mots et leurs relations. Le cours situe l'apparition de la première personne autour de 2-2½ ans et l'enrichissement ultérieur des phrases. Les capacités métasyntaxiques permettent de réfléchir sur la construction des phrases. La pragmatique concerne l'usage du langage en situation : demander, préciser, expliquer, adapter ses paroles à l'interlocuteur.

La compréhension du langage non littéral s'affine : sarcasme, expressions idiomatiques et sens implicites. Le cours donne des repères autour de 8 ans pour certaines formes de sarcasme et autour de 10 ans pour des expressions idiomatiques ; la réussite dépend du contexte et de l'expérience linguistique.

L'apprentissage du langage écrit mobilise notamment une voie phonologique d'assemblage, reliant graphèmes et phonèmes, et une voie lexicale ou orthographique d'identification de mots connus. Déchiffrer ne garantit pas comprendre. Ces voies de traitement ne doivent pas être confondues avec une opposition simpliste entre deux méthodes scolaires.

L'imitation différée reproduit une action après la disparition du modèle. Le jeu symbolique permet de faire semblant et d'explorer des rôles ; il peut aussi aider à reprendre activement une situation subie, par exemple jouer au soignant avec une poupée. Dans un soin, utiliser du matériel de jeu sûr et adapté.

Le dessin évolue du gribouillage et du réalisme fortuit vers une intention de représentation, puis des formes plus organisées. Le réalisme intellectuel peut montrer ce que l'enfant sait plutôt que ce qu'il voit, par exemple un dessin en transparence. Les proportions et la perspective se précisent ensuite. Une particularité isolée de dessin ne prouve pas un conflit ou un diagnostic.

Les images mentales permettent de se représenter un objet absent. Le cours décrit un passage d'images plutôt statiques à des transformations mentalement représentées, vers 7-8 ans dans le modèle piagétien. Manipulations, langage et représentations se soutiennent mutuellement.

La syntaxe se complexifie notamment avec les relations sujet-verbe-objet. Les capacités métasyntaxiques se renforcent avec les apprentissages scolaires, autour de 6-7 ans dans les repères du cours : l'enfant réfléchit à la forme de la phrase et peut en discuter la correction, au-delà de son usage spontané.

Les premières demandes peuvent déjà solliciter une clarification (« quoi ? », vers 1-2 ans dans l'oral), puis une précision (« pourquoi ? », « quand ? », vers 3 ans). Elles deviennent plus ou moins directes selon la familiarité et la disponibilité de l'interlocuteur. La pragmatique se développe donc avant l'âge scolaire et continue à s'affiner ensuite ; elle ne débute pas à 6-7 ans.

Dans le réalisme fortuit, l'enfant attribue après coup une signification à une trace produite : « c'est un dinosaure ». Dans une intention de dessin plus organisée, il cherche d'abord à représenter quelque chose. La possibilité de représenter mentalement des transformations soutient les raisonnements ; une division peut être travaillée en partageant concrètement un gâteau avant d'en évoquer les parts.

Le support officiel clarifie le repère du lexique : il indique une augmentation des mots de classe fermée à partir d'environ 400 mots (p. 21). Il s'agit des mots grammaticaux, tels les déterminants ou prépositions, par opposition aux classes ouvertes comme les noms et verbes. Ce repère de cours ne fixe ni un âge obligatoire ni un seuil de diagnostic. Le réalisme fortuit est situé vers 3 ans et l'amélioration des proportions et de la perspective vers 8-9 ans ; ces indications décrivent une progression variable.

18 · De la pensée préopératoire aux opérations concrètes

Repère : support de N. Khatir, p. 22, 23. Explications et compléments oraux intégrés.

Entre environ 2 et 7 ans, la pensée préopératoire décrite par Piaget utilise des représentations symboliques mais reste souvent centrée sur une dimension perceptive ou sur le point de vue propre. L'égocentrisme cognitif est une difficulté à se décentrer ; il n'est pas un jugement moral d'égoïsme.

L'animisme attribue de la vie ou des intentions aux choses ; l'artificialisme suppose que les phénomènes sont fabriqués par l'homme ; le réalisme matérialise les phénomènes mentaux, par exemple un rêve vécu comme une réalité extérieure. La représentation symbolique peut aussi être très personnelle, comme une pierre utilisée pour représenter un vaisseau.

Entre environ 7 et 12 ans, l'intelligence opératoire concrète se caractérise par la réversibilité logique et la décentration. L'enfant peut se représenter l'annulation ou la compensation d'une transformation. Son raisonnement s'appuie encore volontiers sur des situations concrètes et manipulables.

Les opérations infralogiques structurent les propriétés des objets : conservation de la matière, du poids, du volume, des longueurs et des surfaces, repères spatiaux. Les opérations logico-mathématiques structurent les rapports entre objets : classification, inclusion et sériation. La distinction n'oppose pas deux intelligences indépendantes.

L'inclusion permet de comprendre qu'une sous-classe appartient à une classe plus vaste : s'il y a des roses et des tulipes, il ne peut pas y avoir plus de roses que de fleurs. La sériation ordonne des éléments ; la transitivité permet de déduire que si A est plus grand que B et B plus grand que C, alors A est plus grand que C. La construction du nombre articule ordre, inclusion et conservation numérique.

Conservation	Repères indiqués dans le modèle du cours
Numérique	Vers 7 ans : écarter les mêmes jetons ne change pas leur nombre.
Matière / substance	Vers 7-8 ans : une boule de pâte transformée en galette conserve sa quantité si rien n'est ajouté ni retiré.
Poids	Vers 9-10 ans : modifier la forme d'un objet ne modifie pas son poids dans les mêmes conditions.
Volume	Vers 11-12 ans dans les tâches proposées. Ne pas confondre quantité de matière, poids et volume.
Repères spatiaux	Longueurs et surfaces vers 7 ans ; horizontale/verticale vers 8-9 ans ; volumes spatiaux vers 11-12 ans. Ce sont des repères de tâches, pas des âges de diagnostic.

Difficultés d'apprentissage

Distinguer trouble du langage oral, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Des difficultés répétées peuvent favoriser la résignation apprise : penser que ses efforts ne changeront plus le résultat. Rechercher les obstacles et adapter l'aide. Écrire un seul pseudo-mot ne permet ni de confirmer ni d'exclure une dyslexie.

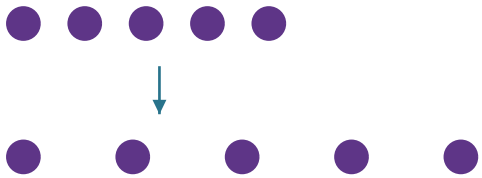
Le cours insiste sur la manipulation pour comprendre les opérations : comparer des réglettes, utiliser une balance, recomposer une surface avec un tangram ou doubler les ingrédients d'une recette. La réversibilité par inversion annule une transformation ; la réciprocité coordonne des relations opposées : si A est plus grand que B, B est plus petit que A. Ces expériences soutiennent le sens des opérations au-delà de leur récitation.

Les troubles cités doivent être différenciés : le trouble développemental du langage oral (appelé dysphasie dans la séance) touche l'expression et/ou la compréhension ; la dyslexie concerne la lecture, la dysorthographie l'orthographe et la dyscalculie les apprentissages du nombre et du calcul. Ils ne se déduisent pas d'une faute ou d'un échec isolé. Une difficulté durable du langage oral peut retentir sur l'accès à l'écrit : repérage, évaluation et aides précoces évitent d'attendre que les échecs s'accumulent [R9].

Le support situe l'inclusion des classes vers 8 ans, la sériation vers 7-8 ans et la construction opératoire du nombre vers 8-8½ ans (p. 23). Cette dernière articule inclusion des classes et relation d'ordre ; elle ne signifie pas que l'enfant ne sait ni compter ni comparer des quantités avant cet âge. Les nombres relatifs et fractions sont évoqués comme prolongements. Les âges restent liés aux tâches du modèle piagétien.

Voir l'invariant derrière une transformation

Conserver le nombre malgré l'espacement



5 jetons avant, 5 après. Aucun ajout ni retrait.

Conserver la matière malgré la forme



Boule → galette : quantité inchangée si toute la pâte est conservée.

La forme change ; la quantité reste identique.

Exemples des tâches de conservation du cours. Le nombre et la matière sont deux propriétés distinctes ; la réussite dépend de la tâche et des conditions.

19 · Théorie de l'esprit : comprendre des points de vue différents

Repère : support de N. Khatir, p. 24. Explications et compléments oraux intégrés.

La théorie de l'esprit est la capacité d'attribuer à soi-même et à autrui des états mentaux : désirs, émotions, intentions, connaissances et croyances. Elle aide à expliquer et anticiper les conduites. Comprendre que quelqu'un peut se tromper demande de distinguer ce qu'il sait de ce que l'on sait soi-même.

Le cours décrit des précurseurs : anticipation de jeux ritualisés, gestes pour être pris dans les bras, attention conjointe, pointage, interprétation d'expressions et adaptation de la présentation d'un objet à l'autre. Aucun de ces comportements ne constitue à lui seul une théorie de l'esprit complète.

Les tâches diffèrent par leur complexité. Dans le cours, l'attribution de désirs est située autour de 2½-3 ans, puis de croyances simples, et la réussite de certaines tâches de fausse croyance autour de 5-6 ans. Des croyances du second ordre, « je pense qu'il croit que… », sont maîtrisées plus tard. La formulation et les exigences de la tâche influencent ces âges.

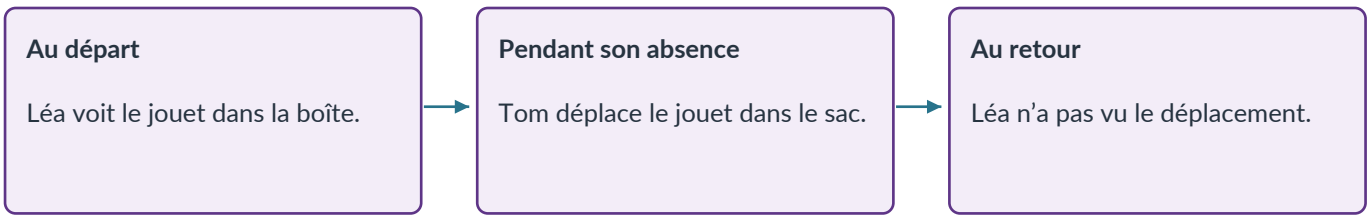
Exemple : Léa range un jouet dans une boîte puis quitte la pièce. Pendant son absence, Tom le déplace dans un sac. L'observateur sait que le jouet est dans le sac ; Léa ne l'a pas vu et devrait d'abord le chercher dans la boîte. Répondre selon la croyance de Léa, plutôt que selon la réalité connue, montre la décentration recherchée.

Ces compétences contribuent aux relations, à la compréhension des intentions et au jugement des actes selon les circonstances. Une difficulté peut avoir plusieurs explications, notamment langagières ou cognitives. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement hétérogène ; les particularités de cognition sociale ne

signifient ni absence d'émotions ni responsabilité des parents [R4].

Pour les tâches évoquées oralement, le cours donne une progression des croyances du second ordre entre environ 8 et 11 ans, puis une analyse plus élaborée des actes selon les circonstances et les intentions vers 12 ans. Ces repères décrivent les tâches du cours ; ils ne fixent ni un âge universel d'acquisition ni une mesure globale de la maturité.

Fausse croyance : savoir où il est ≠ savoir ce qu'elle croit



Réalité connue : le jouet est dans le sac. **Croyance de Léa : le jouet est dans la boîte.**

Pour prédire où Léa cherchera, il faut raisonner à partir des informations qu'elle possède, et non des informations de l'observateur.

20 · Enfance : socialisation, famille et autonomie

Repère : support de N. Khatir, p. 25. Explications et compléments oraux intégrés.

La famille, les pairs, l'école et les médias participent à la socialisation. Les ressources matérielles et culturelles, les échanges de langage et les occasions d'activité influencent les expériences. Une association statistique entre ressources et réussite n'autorise pas à prédire le devenir d'un enfant particulier.

Le cours présente trois styles éducatifs : contractualiste, plutôt démocratique, avec règles expliquées et discussion ; statutaire, plus autoritaire et fondé sur le statut de l'adulte ; maternaliste, mettant l'accent sur la cohésion et la protection avec une marge de décision parfois réduite. Ce sont des descriptions de configurations, pas des diagnostics de familles.

Les rapports de contrainte et d'autorité unilatérale peuvent évoluer vers la coopération, la réciprocité et une autonomie progressive. L'hétéronomie signifie que la règle est reçue d'autrui ; l'autonomie, que le sujet peut se l'approprier et se déterminer. Elle ne signifie pas être laissé seul sans soutien.

Les pairs offrent des occasions d'alternance, de négociation, de partage et de décentration. Les conflits ordinaires peuvent être des situations d'apprentissage ; harcèlement, violences et exclusion persistante nécessitent une réponse protectrice.

L'enfant construit aussi des identifications concernant son corps, son appartenance et les catégories sociales. Distinguer caractéristiques corporelles, identité de genre, expression de genre et stéréotypes. Une préférence de vêtement ou de jeu ne constitue pas un diagnostic. Les repères historiques du cours sur la « constance de l'appartenance sexuée » concernent une compréhension des catégories et ne permettent pas de juger la légitimité d'une identité.

La contagion émotionnelle est évoquée dès le nourrisson : un bébé peut se mettre à pleurer en entendant un autre pleurer. Cette résonance précoce ne se confond pas avec une compréhension complète de l'émotion et du point de vue d'autrui. Le cours rattache à Wallon l'importance des échanges émotionnels dans le développement.

La cohésion familiale et la marge d'individualisation constituent aussi des axes de description : certaines activités et règles sont très partagées, d'autres laissent plus de choix individuels. Explorer le fonctionnement réel aide à comprendre les attentes et les conflits. Les pairs apportent des modèles d'identification et des occasions de coopération ; leur influence dépend du contexte.

Le support nomme deux formes de cohésion familiale : famille « bastion » et famille « association » (p. 25). Dans les explications du cours, la première privilégie le collectif et les activités communes ; la seconde laisse davantage de place aux choix et activités individuels. Ce sont des repères descriptifs, pas des étiquettes de bonne ou mauvaise famille. Le support évoque aussi le passage de leaders appréciés pour leur force ou adresse vers 7-9 ans à des leaders appréciés pour leur équité et solidarité vers 10 ans ; ces observations historiques ne sont pas universelles.

21 · Adolescence : intégrer le corps et remanier l'identité

Repère : support de N. Khatir, p. 26, 31. Explications et compléments oraux intégrés.

L'adolescence est une période de remaniement affectif, cognitif et social en lien avec les transformations pubertaires. Le cours reprend l'idée d'une évolution lente et profonde, parfois ponctuée de ruptures, touchant corps, personnalité, comportements et relations à soi et aux autres. Son enjeu est notamment d'intégrer les modifications de la puberté à l'organisation de la personnalité.

La puberté transforme les caractères sexuels et les capacités reproductives ; son calendrier varie. Elle ne se confond ni avec la maturité affective, ni avec l'autonomie financière, ni avec la majorité légale. Le passage à l'âge adulte ne possède donc pas un seul indicateur.

Le corps devient une préoccupation centrale : changements de taille, d'apparence, de sensations et d'image de soi. Les inquiétudes corporelles, les comparaisons avec les pairs et les normes médiatiques peuvent être importantes. Une insatisfaction n'est pas automatiquement une dysmorphophobie ; apprécier intensité, persistance et retentissement.

La « crise » peut se comprendre comme un moment décisif de transformation, sans guerre familiale obligatoire. Les contextes culturels, les rites de passage et les conditions sociales modulent son expression. La maturation ne s'achève pas à un anniversaire identique pour tous.

La construction identitaire articule un sentiment de continuité temporelle, de cohésion et de singularité malgré les changements. Le moratoire identitaire, dans les travaux de Marcia évoqués par le cours, associe une exploration active à des engagements encore peu stabilisés. Il ne signifie ni absence d'identité ni échec.

22 · Pensée formelle, argumentation et lecture

Repère : support de N. Khatir, p. 27, 28. Explications et compléments oraux intégrés.

Dans le modèle de Piaget, les opérations formelles apparaissent à partir d'environ 12 ans et s'organisent davantage vers 14-15 ans. La pensée hypothético-déductive permet de poser des hypothèses, d'en tirer des conséquences et de les confronter aux faits. Elle ne nécessite plus toujours de réaliser concrètement l'action pour la comprendre.

La combinatoire explore systématiquement plusieurs combinaisons possibles. La logique des propositions porte sur les relations entre énoncés : « et », « ou », négation, implication « si… alors… ». Une conclusion doit suivre des prémisses ; changer une prémisse peut changer ce que l'on peut déduire.

Le groupe INRC de Piaget articule Identité, Négation, Réciproque et Corrélative. Le cours l'illustre par un escargot sur une planche mobile : déplacement propre, déplacement inverse, déplacement compensateur du support, déplacement du support dans le même sens. La compensation suppose des déplacements de même amplitude en sens opposés. Il s'agit d'une illustration du modèle, pas d'une formule générale de toute pensée.

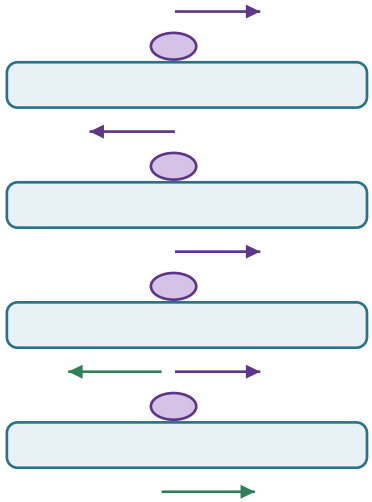
Cette pensée soutient une vision plus vaste du monde, le raisonnement sur le possible, les probabilités et le futur, l'introspection et la hiérarchisation des valeurs. Son usage dépend des apprentissages, des tâches et du contexte ; elle n'est pas automatiquement maîtrisée dans tous les domaines à un âge donné.

L'argumentation se raffine : adapter ses raisons à l'interlocuteur, articuler arguments et contre-arguments, concession, restriction et justification. La lecture-compréhension intègre le type de texte, la ponctuation et les éléments qui l'entourent, comme titres, notes et illustrations. Le vocabulaire reste déterminant.

Distinguer illettrisme et analphabétisme : l'illettrisme concerne des personnes scolarisées qui ne maîtrisent pas suffisamment l'écrit pour les situations ordinaires ; l'analphabétisme désigne l'absence d'apprentissage initial de la lecture et de l'écriture. L'allophonie est le fait d'avoir une autre langue première que celle du milieu considéré ; elle n'est ni un trouble intellectuel ni un illettrisme.

Les premiers arguments sont situés vers 3 ans et leur adaptation à l'interlocuteur vers 4 ans ; une argumentation plus élaborée, mobilisant contre-arguments, concession, restriction, justification et négociation, se renforce vers 14-15 ans dans les repères du support (p. 28). Le métatexte désigne ici les éléments qui accompagnent et organisent le texte (titres, notes, indications) et orientent la lecture-compréhension.

INRC : combiner deux déplacements dans le modèle du cours



I · Identité — Avance propre

N · Négation — Mouvement inverse

R · Réciproque — Compensation

C · Corrélative — Déplacements associés

Violet : mouvement propre ; vert : mouvement du support. Compensation si les déplacements opposés sont égaux.

Illustration par un mobile sur un support. Dans la situation de compensation, le déplacement par rapport à l'observateur est nul. Ce dessin n'est pas une mesure expérimentale.

23 · Kohlberg : raisonner sur un dilemme moral

Repère : support de N. Khatir, p. 28. Explications et compléments oraux intégrés.

Kohlberg étudie le raisonnement moral à partir de dilemmes. Dans celui de Heinz, un homme doit décider s'il vole un médicament inaccessible financièrement pour sauver sa femme. L'enjeu est la justification : pourquoi juge-t-on l'acte acceptable ou inacceptable, et que change une variation de situation ?

Le modèle distingue trois niveaux comprenant chacun deux stades. Ils décrivent la structure du raisonnement, et non la valeur personnelle d'un individu. Les âges ne sont pas des étapes mécaniques ni une preuve que chaque adulte atteint le dernier niveau.

Niveau	Logique du jugement
Préconventionnel · stades 1-2	1 : obéissance et évitement de la punition. 2 : intérêt individuel, récompense et échange instrumental. Ce qui compte est d'abord la conséquence pour soi.

Niveau	Logique du jugement
Conventionnel · stades 3-4	3 : conformité aux attentes des proches, loyauté et bonnes relations. 4 : respect des règles, des lois et du fonctionnement de la société. Le cours les situe davantage à partir de la fin de l'enfance et de l'adolescence.
Postconventionnel · stades 5-6	5 : contrat social et examen critique des règles à partir des droits et de leur fonction. 6 : principes éthiques universalisables, pouvant conduire à une position minoritaire face à une règle jugée injuste.

Jugement et conduite

Savoir justifier moralement un acte ne garantit pas de se comporter conformément à cette justification. Les débats, la prise de perspective et l'explication des règles soutiennent ce travail. Le modèle éclaire un raisonnement ; il ne donne pas au soignant un droit général d'ignorer la loi.

L'idéologie est abordée comme l'accès à un raisonnement abstrait sur la politique, l'éducation ou la religion, référé à des principes généraux plutôt qu'à des opinions particulières. Elle intègre l'évolution historique et politique des idées (p. 28). Elle ne se confond pas avec le stade moral de Kohlberg ; jugement et conduite effectifs doivent également être distingués.

24 · Pairs, famille et nouveaux liens à l'adolescence

Repère : support de N. Khatir, p. 29, 30. Explications et compléments oraux intégrés.

L'estime de soi peut fluctuer avec les transformations corporelles, les changements scolaires et les comparaisons. Les pairs sont un lieu d'échange, d'identification et d'intégration. Les amitiés permettent d'expérimenter des rôles et d'accompagner la séparation psychique d'avec les parents.

Les compétences sociales comprennent l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle, une cognition sociale suffisamment ajustée et la résolution de problèmes interpersonnels. Le sentiment d'efficacité personnelle concerne la croyance de pouvoir agir dans une situation ; le lieu de contrôle interne concerne l'attribution des résultats à ses actions. Ce sont des notions liées mais distinctes.

Dunphy distingue dans le modèle présenté les cliques, petits groupes proches souvent de même sexe dans les observations historiques, puis des bandes plus larges et plus mixtes facilitant les rencontres. Des couples plus stables peuvent ensuite se former. Cette séquence n'est pas une obligation de sociabilité ni une norme d'orientation sexuelle.

L'autonomie comportementale est l'ensemble des décisions et actions que l'adolescent peut réaliser sans recourir chaque fois à l'autorisation parentale : organisation quotidienne, sorties, apparence ou certains choix. Elle se négocie progressivement selon les capacités et les responsabilités, avec un cadre qui reste protecteur.

Les liens parentaux se remanient sans nécessairement disparaître. Les conduites d'opposition peuvent participer à la recherche de différenciation, mais il faut explorer leur sens et leur retentissement plutôt que les banaliser. Les parents peuvent rester une base de sécurité, tandis que de nouveaux liens amicaux et amoureux prennent de l'importance.

Un cadre trop rigide peut entraver l'appropriation des règles ; une absence de limites peut être vécue comme un abandon. Chercher une présence fiable qui reconnaît la subjectivité, la vie privée et les capacités de négociation. L'intimité ne doit pas être confondue avec une absence de soutien.

Dunphy décrit des groupes primaires ou cliques (environ 3-9 membres) et des groupes secondaires ou bandes (environ 10-30), avec élargissement du réseau et rencontres nouvelles (p. 29). L'adolescence remanie aussi le système d'attachement : les relations parentales restent des appuis possibles, tandis que les liens amicaux et

amoureux, le système sexuel et le caregiving prennent davantage de place (p. 30). Les tailles et séquences sont des descriptions du modèle, sans obligation individuelle.

25 · Adolescents en difficulté : repérer et accompagner

Repère : support de N. Khatir, p. 31. Explications et compléments oraux intégrés.

Les difficultés scolaires peuvent associer obstacles d'apprentissage, sentiment d'échec, anxiété, conflits ou autres souffrances. Le refus scolaire anxieux ne se réduit pas à un manque de volonté. Des angoisses de séparation peuvent intervenir, sans constituer l'unique explication. Examiner aussi le contexte scolaire, les relations et les éventuelles violences.

Les événements stressants, les pertes, le rejet, les difficultés sentimentales et la fragilisation de l'estime de soi peuvent contribuer à une décompensation. Une souffrance persistante, un retrait, un changement important du fonctionnement ou des propos suicidaires appellent une évaluation et une réponse protectrice. Ne pas tout attribuer à une « crise normale ».

Les conduites agressives, les transgressions ou la consommation de substances s'apprécient selon leur fréquence, leur contexte, leurs conséquences et les ressources disponibles. Le rôle infirmier associe écoute, observation, transmission, sécurité et travail avec les professionnels concernés.

Repères juridiques rectifiés : la responsabilité pénale d'un mineur dépend du discernement, avec des présomptions différentes de part et d'autre de 13 ans ; la formule « responsabilité à 13 ans » est trop simplificatrice. Une mineure peut recourir à une IVG sans autorisation parentale dans le cadre prévu, avec l'accompagnement d'un majeur de son choix si elle souhaite garder le secret. L'émancipation judiciaire peut être demandée à partir de 16 ans passés selon la procédure applicable ; le placement n'est pas, à lui seul, une interdiction générale [R6-R8].

26 · Vieillissement : pertes, investissements et attachement

Repère : support de N. Khatir, p. 32, 33. Explications et compléments oraux intégrés.

Le vieillissement est associé à des transformations corporelles, sociales et psychiques très variables. Retraite, réduction de certaines capacités, décès de proches ou changement de lieu de vie peuvent modifier les repères. Les représentations culturelles, notamment le jeunisme, influencent aussi l'expérience et le regard d'autrui.

Le narcissisme, au sens de l'investissement du Moi et de l'image de soi, peut être mis à l'épreuve. La finitude confronte à la condition mortelle ; des pertes multiples demandent des remaniements. Il reste possible d'investir de nouvelles personnes, activités et responsabilités. Vieillir ne signifie pas nécessairement devenir dépressif.

Les mécanismes de défense évoqués sont la régression, le déni et la dénégation. La régression est le recours à des modalités de fonctionnement plus anciennes ; le déni refuse une réalité éprouvante ; la dénégation laisse apparaître un contenu tout en refusant de le reconnaître comme sien. Ne pas qualifier tout désaccord du patient de défense.

L'attachement persiste toute la vie. À l'âge adulte, la réciprocité permet d'être tour à tour soutenu et soutenant. Devenir parent ou aider un proche en détresse mobilise à la fois l'attachement et le caregiving. Les représentations peuvent soutenir une sécurité intérieure lorsque l'autre est absent.

À un âge avancé, vulnérabilité et dépendance peuvent réactiver les besoins de réconfort. Conjoint, descendants, fratrie, amis ou proches peuvent constituer des figures importantes. Après leur disparition, souvenirs, lieux, objets familiers ou animaux peuvent soutenir le lien symbolique.

Même en présence d'une détérioration cognitive, une familiarité émotionnelle et des relations de réconfort peuvent rester mobilisables. Personnaliser l'environnement, maintenir une continuité relationnelle et respecter la manière dont la personne accepte le contact. Le toucher n'est proposé qu'avec son accord et selon son

confort.

Le style d'attachement adulte désigne des configurations d'attentes, besoins, émotions, stratégies de régulation émotionnelle et comportements sociaux (p. 33). La relation d'attachement est un lien affectif durable dont le partenaire est vécu comme unique et non interchangeable, et dont la proximité est souhaitée. La réciprocité permet à chacun de recevoir et de fournir soutien, attention et sécurité ; la base de sécurité s'appuie davantage sur les échanges verbaux et une sécurité intériorisée que sur le seul contact physique.

L'attachement symbolique correspond au réconfort obtenu par l'évocation et les souvenirs d'une figure absente ou disparue. Les objets et lieux familiers peuvent faciliter cette évocation (p. 33). Chez la personne âgée, les enfants adultes peuvent devenir des figures d'attachement importantes. Les troubles neurocognitifs ne suppriment pas les besoins de sécurité et de relation : la réponse reste ajustée aux capacités et aux préférences de la personne.

27 · Les mémoires : enregistrer, maintenir et retrouver

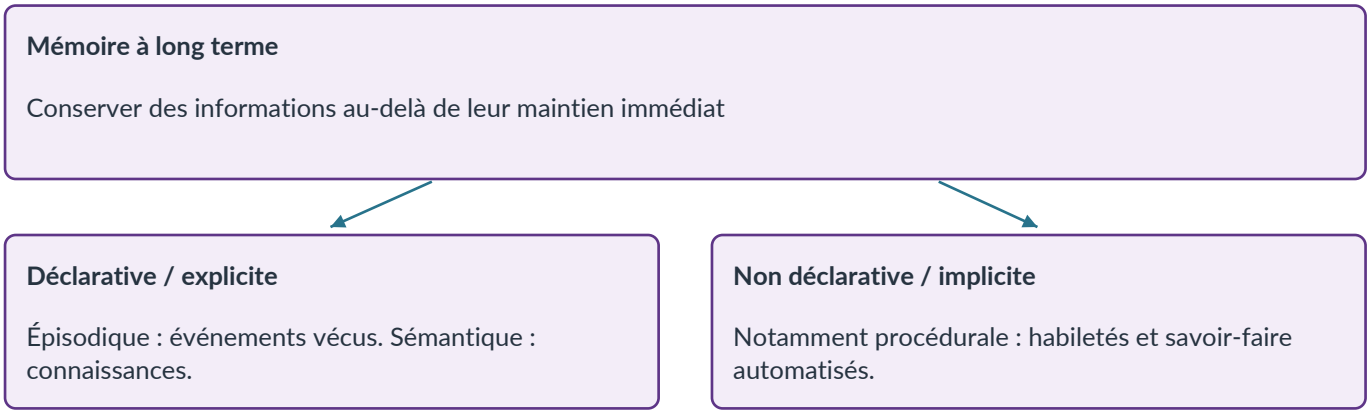
Repère : support de N. Khatir, p. 34. Explications et compléments oraux intégrés.

La mémoire est l'ensemble des capacités permettant d'encoder, de conserver et de récupérer des informations et des connaissances. L'encodage traite l'information pour la mémoriser, le stockage la maintient, la récupération la rend à nouveau disponible. L'attention conditionne largement ce qui pourra être encodé.

Les modèles distinguent plusieurs systèmes selon la durée, le contenu et le mode d'accès. Les frontières sont des outils de compréhension, pas des compartiments anatomiques indépendants. La mémoire de travail ne se réduit pas à conserver passivement quelques éléments : elle permet leur manipulation dans une activité.

Système	Fonction et exemple
Mémoire sensorielle	Maintien très bref d'informations sensorielles ; permet une continuité initiale de traitement. La durée dépend de la modalité, sans durée unique valable pour tous les sens.
Mémoire à court terme	Maintien temporaire d'une petite quantité d'information, par exemple un numéro le temps de le composer.
Mémoire de travail	Maintien et manipulation : garder une consigne en tête, sélectionner les données utiles et les organiser pour une tâche ou un calcul.
Mémoire à long terme déclarative / explicite	Contenus accessibles au rappel conscient : mémoire épisodique d'événements situés et mémoire sémantique des connaissances générales.
Mémoire épisodique	Se souvenir d'une rencontre vécue, avec son contexte temporel et spatial.
Mémoire sémantique	Connaître le sens d'un mot, un concept ou une règle, sans devoir revivre l'épisode où on l'a appris.
Mémoire non déclarative / implicite	Effets d'expériences antérieures sans rappel conscient nécessaire ; elle comprend notamment la mémoire procédurale des savoir-faire.
Mémoire procédurale	Savoir faire du vélo ou réaliser un geste bien appris, sans détailler consciemment chaque mouvement.

Organiser les mémoires à long terme



Classification simplifiée issue du cours. La mémoire procédurale appartient à la mémoire non déclarative ; elle n'en épuise pas toutes les formes.

28 · Vieillissement cognitif, dépression et troubles neurocognitifs

Repère : support de N. Khatir, p. 34, 35. Explications et compléments oraux intégrés.

Le vieillissement peut ralentir le traitement de l'information et modifier l'attention ou la mémoire de travail. Les trajectoires sont hétérogènes. L'intelligence fluide concerne surtout le raisonnement face à des situations nouvelles ; l'intelligence cristallisée s'appuie sur les connaissances et l'expérience et peut rester longtemps préservée.

La reconnaissance, aidée par la présence d'un indice, peut être plus facile que le rappel sans aide. Une plainte mnésique n'implique pas automatiquement une maladie neurodégénérative : anxiété, dépression, fatigue, difficultés sensorielles ou contexte peuvent intervenir. Inversement, l'absence de plainte ne rassure pas toujours en cas d'anosognosie.

Le langage peut être moins rapide ou moins complexe sans disparition des compétences narratives et conversationnelles. Ajuster le débit, laisser du temps, vérifier l'audition et la compréhension, maintenir des échanges adultes et des activités qui ont du sens.

Le trouble neurocognitif majeur, anciennement appelé démence, implique un déclin acquis significatif d'un ou plusieurs domaines cognitifs qui compromet l'autonomie. Contrairement à la formulation historique du support, une atteinte de la mémoire n'est pas obligatoire dans toutes les formes. Les troubles neurocognitifs ne sont pas une conséquence normale ou inévitable de l'âge [R5].

La maladie d'Alzheimer est une cause fréquente. Le cours décrit des difficultés de mémorisation, puis des atteintes possibles du raisonnement, du langage et des praxies. Une apraxie perturbe des gestes appris, comme s'habiller. Les manifestations, l'ordre d'apparition et l'évolution varient selon la maladie et la personne.

Dépression et trouble neurocognitif peuvent se ressembler sur certains aspects et coexister. Chez la personne âgée, tristesse, ralentissement, sommeil et difficultés de concentration s'interprètent dans le contexte et l'évolution. Ne pas banaliser la souffrance ou les propos de mort au motif de l'âge. Le risque suicidaire demande une évaluation attentive.

Pour les proches, les changements de conduite, la non-reconnaissance et l'augmentation des aides peuvent être éprouvants. Soutenir les aidants, rechercher l'épuisement et associer les professionnels. Une institutionnalisation ne constitue pas en soi un abandon ni une preuve d'échec familial.

Préserver la personne

Soutenir l'autonomie restante, proposer des activités accessibles, maintenir les liens et rechercher les causes d'un changement. Éviter l'infantilisation et la mise à distance. Une perte de capacité ne supprime ni la dignité, ni les préférences, ni la possibilité d'un lien.

29 · Repères de lecture et rectifications

Source principale : N. Khatir, Support de cours Psychologie du développement, 2026, 35 pages. Les chapitres sont confrontés à l'ensemble de ce document ; les apports des transcriptions déjà examinées sont conservés. Les pages 13-14 documentent désormais le langage de 0 à 2 ans et les premiers échanges. La psychométrie ne figure pas dans ces 35 pages : elle reste hors du présent support.

Les références ci-dessous servent à rectifier ou encadrer des formulations cliniques et juridiques. Elles ne remplacent pas le périmètre enseigné et ne créent pas de priorités d'examen. Les dates d'acquisition de Piaget restent présentées comme repères de son modèle, distincts des seuils de repérage clinique.

Repère	Référence de la rectification
R1 · Variabilité motrice	OMS, étude des acquisitions motrices : https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/motor-development-milestones
R2 · Énurésie	Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/pipi-lit-enuresie/reconnaitre-enuresie-nocturne-enfant
R3 · Encoprésie	SNFCP : https://www.snfcp.org/informations-maladies/constipation-et-incontinence/encopresie-de-lenfant/
R4 · Repérage du TSA	HAS, signes d'alerte, repérage et diagnostic : https://www.has-sante.fr/jcms/c_468812/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement
R5 · Trouble neurocognitif	Assurance Maladie, définition et diagnostic : https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/sante-mentale-soins-primaires/seniors/troubles-neurocognitifs-severes-senior-personne-agee
R6 · Discernement du mineur	Ministère de la Justice : https://www.justice.gouv.fr/justice-france/justice-mineurs/justice-penale-mineurs
R7 · IVG	Service Public : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1551
R8 · Émancipation	Service Public : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1194
R9 · Langage et apprentissages	HAS, parcours de santé : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages
R10 · Parole et bégaiement	Ministère de la Santé, prévention : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_begaiement-2.pdf ; Assurance Maladie, prise en charge : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/trouble-expression-langage-oral-enfant/traitement

Repère	Référence de la rectification
R11 · Prévalence / incidence	INED, lexique : https://www.ined.fr/fr/lexique/incidence-maladie et https://www.ined.fr/fr/lexique/prevalence-maladie
R12 · Transmission génétique	NHGRI, hérédité mendélienne : https://www.genome.gov/genetics-glossary/Mendelian-Inheritance ; liaison génétique : https://www.genome.gov/genetics-glossary/Linkage. Les lois simples ne décrivent pas toutes les transmissions.

30 · Pièges QCM et confusions à éviter

Ne pas confondre	Distinction à conserver
Inné / acquis	Le développement résulte d'interactions ; ni maturation seule, ni environnement seul.
Âge moyen / diagnostic	Une variation ou un geste isolé ne suffit pas ; apprécier trajectoire et retentissement.
Désir de grossesse / projet / désir d'enfant	État corporel recherché, démarche consciente et investissement de l'enfant sont trois plans distincts.
Assimilation / accommodation	Intégrer à un schème existant / modifier le schème.
Primaire / secondaire / tertiaire	Corps propre / effet sur un objet / variation expérimentale des actions.
Permanence de l'objet / sécurité affective	Comprendre l'existence hors perception / pouvoir s'appuyer sur une relation dans l'absence.
Attachement / comportement d'attachement	Lien durable / conduite observable destinée à retrouver de la proximité.
Calme / sécurité	L'absence de pleurs n'est ni la preuve d'une sécurité ni la preuve d'un trouble.
Évitant / désorganisé	Stratégie organisée avec minimisation du contact / rupture ou contradiction de l'organisation à certains moments.
Caregiver / caregiving	Personne qui prend soin / système de protection et de réconfort.
Doudou / objet transitionnel	Un objet proposé par l'adulte n'a cette fonction que s'il est investi ainsi par l'enfant.
Égocentrisme / égoïsme	Difficulté cognitive de décentration / jugement moral sur une conduite.
Théorie de l'esprit / empathie	Attribuer des états mentaux / comprendre ou partager l'expérience affective d'autrui.
Conservation / apparence	Forme, espacement ou disposition peuvent changer sans changement de quantité.
Jugement moral / conduite	Une justification élaborée ne garantit pas l'action correspondante.
Autonomie / abandon	S'approprier des règles et décider progressivement demande encore un cadre et des soutiens.
Vieillissement / démence	Le trouble neurocognitif n'est pas une conséquence inévitable de l'âge.
Plainte / déficit objectivé	Une plainte peut avoir plusieurs causes ; l'anosognosie peut masquer un trouble.
Déni / dénégation	Refus d'une réalité / contenu formulé puis désavoué.
Repérage / diagnostic	Observer et orienter ne permet pas d'étiqueter une personne à partir d'un seul signe.

31 · Synthèse générale et application au soin

Partir des faits : « l'enfant détourne le regard pendant le soin », « il tend les bras au retour du parent », « la personne cherche ses mots mais raconte un souvenir avec plaisir ». Séparer observation, hypothèse explicative et diagnostic.

Nommer puis définir le concept utile et justifier son lien avec les faits. Exemple : après une séparation, un enfant retrouve son parent, accepte le réconfort et reprend le jeu ; cette séquence illustre l'usage de la figure comme base de sécurité. Elle ne suffit pas à attribuer définitivement une catégorie d'attachement.

Adapter l'information au niveau de compréhension : montrer et manipuler avec un enfant, employer des phrases simples et correctes avec le tout-petit, discuter les raisons avec l'adolescent, laisser du temps et des indices avec une personne âgée. Vérifier ce que la personne a compris.

La réponse soignante peut associer continuité, prévisibilité, réconfort, respect de l'autonomie et coordination. L'environnement relationnel compte à tout âge ; il ne doit jamais faire négliger douleur, maladie, difficultés sensorielles ou besoins de protection.

32 · Définitions et mots-clés

222 définitions de révision. Les extraits littéraux sont explicitement signalés ; les autres formulations sont des explications personnelles du cours.

Terme	Définition
Psychologie du développement	Étude de la genèse et des transformations des conduites et des systèmes qui les organisent sur l'ensemble de l'existence. Extrait du support, p. 2 : « étude de la genèse des conduites et des systèmes qui la structurent, s'appliquant à l'ensemble de l'existence (et donc fonction de l'âge) »
Psychologie de l'enfant	Étude des compétences, performances et fonctionnements psychologiques des enfants, avec notamment des applications éducatives.
Inné	Ce qui relève de dispositions biologiques présentes précocement ; leur expression s'inscrit dans une interaction avec le milieu.
Acquis	Ce qui se construit par l'expérience, l'apprentissage et les interactions au cours de la vie.
Génotype	Ensemble des caractéristiques génétiques d'un individu, distinct des caractéristiques directement observables.
Phénotype	Caractéristiques observables résultant de l'expression du patrimoine génétique dans un environnement.
Épigenèse	Construction progressive de l'organisation et du fonctionnement par des interactions entre dispositions et expériences, au sens du cours.
Plasticité cérébrale	Capacité des réseaux nerveux à se modifier au cours du développement et sous l'effet de l'expérience.
Norme statistique	Repère fondé sur la fréquence ou la distribution d'une caractéristique dans une population ; elle ne suffit pas à définir la santé.
Norme sociale	Attente ou règle de conduite partagée dans un groupe, variable selon la culture et l'époque.
Pathologique	Qui concerne une maladie ou un fonctionnement entraînant des difficultés significatives, à apprécier selon plusieurs critères et dans un contexte.
Désir de grossesse	Dans la lecture psychodynamique du cours, désir de vivre l'état de grossesse et les expériences corporelles ou psychiques qui lui sont associées.
Projet d'enfant	Démarche consciente d'intégration d'un enfant à un projet de vie, individuel ou familial.
Désir d'enfant	Investissement de l'idée d'avoir un enfant, comportant des composantes conscientes et inconscientes dans le modèle présenté.

Terme	Définition
Enfant imaginaire	Enfant représenté à partir des souhaits, attentes, fantasmes et projections des futurs parents.
Enfant réel	Enfant rencontré dans sa singularité et ses besoins propres, distinct des représentations parentales.
Deuil de l'enfant imaginaire	Remaniement des attentes permettant de reconnaître et d'accueillir l'enfant réel.
Mandat transgénérationnel	Attentes ou missions transmises entre générations et attribuées à un enfant, de manière plus ou moins explicite.
Ambivalence	Coexistence d'affects ou de tendances opposées envers un même objet ou une même situation.
Identification	Processus par lequel un sujet s'approprie des caractéristiques d'une autre personne et transforme ainsi sa propre organisation.
Préoccupation maternelle primaire	Concept de Winnicott décrivant une sensibilité particulière aux signaux et besoins du bébé en fin de grossesse et dans les premières semaines après la naissance. Extrait du support, p. 16 : « état psychique particulier de la mère qui prend naissance pendant la grossesse et qui se prolonge après la naissance, sorte de folie maternelle caractérisée par une adaptation et une hypersensibilité aux états internes et signaux de son bébé(tout ce qu'il lui communique), »
Couvade psychosomatique	Manifestations corporelles rapportées chez certains futurs pères pendant la grossesse de leur partenaire, sans caractère obligatoire.
Néoténie	Persistance ou prolongation de caractéristiques d'immaturité ; dans le cours, elle souligne la grande dépendance initiale du nouveau-né humain.
Réflexe archaïque	Réponse motrice précoce automatique recherchée lors de l'examen neurologique du nourrisson, dont l'évolution dépend du réflexe considéré.
Tonus	État de tension des muscles participant au maintien postural et à l'ajustement des mouvements.
Progression céphalo-caudale	Organisation du contrôle moteur allant globalement de la tête vers les parties inférieures du corps.
Progression proximo-distale	Organisation du contrôle moteur allant globalement de l'axe corporel vers les extrémités.
Préhension	Action de saisir un objet ; ses modalités deviennent progressivement plus précises.
Coordination visuo-manuelle	Ajustement des mouvements de la main aux informations visuelles pour orienter une action.
Pince pouce-index	Prise fine d'un objet entre le pouce et l'index, permettant des manipulations plus précises.

Terme	Définition
Contrôle sphinctérien	Capacité progressive à percevoir les besoins d'élimination et à contrôler volontairement les fonctions concernées dans un contexte adapté.
Énurésie nocturne	Mictions involontaires répétées pendant le sommeil à un âge où le contrôle est attendu, usuellement à partir de 5 ans ; elle demande une appréciation clinique.
Encoprésie	Émissions répétées de selles dans des endroits inappropriés chez un enfant d'au moins 4 ans, avec recherche des causes et du contexte.
Discrimination perceptive	Capacité à différencier des stimuli selon leurs caractéristiques.
Catégorisation	Regroupement d'éléments à partir de propriétés communes, permettant d'organiser les connaissances.
Coordination intersensorielle	Mise en relation d'informations provenant de plusieurs modalités sensorielles.
Permanence de l'objet	Compréhension progressive qu'un objet continue à exister lorsqu'il n'est plus directement perçu.
Erreur A-non-B	Recherche persistante d'un objet en A, lieu de découvertes antérieures, après qu'il a été caché en B sous les yeux de l'enfant.
Schème	Organisation d'action ou de pensée réutilisable dans des situations comparables, notion centrale chez Piaget. Extrait du support, p. 11 : « actions fondamentales de la connaissance, soit physiques telles vision, succion, préhension etc., soit mentales telles classement, comparaison etc. »
Adaptation	Ajustement des conduites aux rapports entre l'organisme et son milieu, par assimilation et accommodation dans le modèle piagétien. Extrait du support, p. 11 : « ensemble des modifications des conduites permettant un équilibre des relations entre l'organisme et son milieu »
Assimilation	Intégration d'une donnée nouvelle à un schème existant sans transformation essentielle de celui-ci. Extrait du support, p. 11 : « intégration de nouvelles données à des conduites antérieures »
Accommodation	Modification d'un schème pour rendre possible le traitement de données nouvelles. Extrait du support, p. 11 : « transformation d'un schème de conduite antérieur pour le rendre compatible avec le traitement de nouvelles données »
Équilibration	Processus de réorganisation des schèmes visant une cohérence entre connaissances et situations rencontrées.
Intelligence sensori-motrice	Organisation de la connaissance à partir de la perception et de l'action, avant la place centrale des représentations, jusqu'à environ 2 ans chez Piaget.
Intelligence préopératoire	Dans le modèle de Piaget, pensée symbolique encore limitée par la centration et une réversibilité logique incomplète, située approximativement entre 2 et 7 ans.

Terme	Définition
Intelligence opératoire concrète	Dans le modèle de Piaget, raisonnement réversible et décentré portant surtout sur des situations concrètes, approximativement entre 7 et 12 ans.
Intelligence opératoire formelle	Dans le modèle de Piaget, raisonnement sur des hypothèses et relations entre propositions, se développant à partir de l'adolescence sans maîtrise universelle dans tous les domaines.
Réaction circulaire primaire	Répétition d'une action initialement fortuite et intéressante, centrée sur le corps propre.
Réaction circulaire secondaire	Répétition d'une action produisant un effet intéressant sur un objet extérieur.
Réaction circulaire tertiaire	Exploration par variation volontaire des actions et observation de leurs effets.
Intentionnalité	Organisation d'une conduite orientée vers un but, avec mobilisation progressive des moyens pour l'atteindre.
Insight	Apparition d'une solution par réorganisation ou combinaison mentale, plutôt que par les seuls essais moteurs successifs.
Imitation différée	Reproduction d'un modèle après sa disparition de la situation perceptive immédiate.
Prosodie	Rythme, accentuation et variations d'intonation de la parole, participant au sens et aux échanges affectifs.
Phonème	Unité sonore distinctive permettant de différencier des mots dans une langue.
Graphème	Unité écrite, formée d'une ou plusieurs lettres, correspondant à une unité du système de la langue écrite.
Babillage	Productions vocales prélinguistiques organisées en suites de sons et de syllabes.
Lallation	Répétition de suites consonne-voyelle, comme « ba-ba », dans les productions du nourrisson.
Lexique	Ensemble des mots disponibles dans une langue ou chez une personne ; distinguer vocabulaire compris et produit.
Syntaxe	Organisation des mots et des relations grammaticales dans les énoncés.
Style référentiel	Profil d'acquisition du langage privilégiant notamment les noms et la désignation d'objets.
Style expressif	Profil d'acquisition du langage utilisant volontiers des expressions ou fragments de phrases dans l'interaction.
Mot pivot	Mot réutilisé avec plusieurs autres dans les premiers énoncés, par exemple « encore » associé à différentes demandes.

Terme	Définition
Mot-phrase / holophrase	Mot dont le sens communicatif équivaut à un énoncé plus large, interprété grâce au contexte.
Pointage / pointing	Geste orienté vers un objet ou événement pour demander ou partager un intérêt avec autrui.
Attention conjointe	Partage d'attention entre deux personnes à propos d'un même objet ou événement, avec une dimension de partage social.
Tour de rôle	Alternance ajustée des contributions des partenaires dans une interaction.
LAE	Langue adaptée à l'enfant : parole ajustée aux possibilités de l'enfant, souvent plus lente, concrète, répétitive et syntaxiquement correcte.
Étayage	Appui apporté par un partenaire pour permettre une activité ou une acquisition ; ici, ajustement de l'aide dans l'interaction. À distinguer de l'étayage pulsionnel psychanalytique.
Attachement	Lien affectif durable avec une ou quelques figures privilégiées, recherchées comme source de sécurité et de réconfort en situation de détresse. Extrait du support, p. 17 : « L'attachement constituerait un besoin social primaire => tendance originelle et permanente à rechercher la relation avec autrui, l'attachement une fois formé ayant pour nature de durer. Sa fonction à l'échelle de l'espèce est vraisemblablement double : de protection à l'égard des prédateurs et de survie. »
Comportement d'attachement	Conduite favorisant le maintien ou le rétablissement d'une proximité avec une figure d'attachement. Extrait du support, p. 17 : « Comportements du bébé destinés à favoriser la proximité avec l'objet d'attachement »
Figure d'attachement	Personne vers laquelle les conduites d'attachement sont préférentiellement dirigées et dont la disponibilité soutient la sécurité. Extrait du support, p. 17 : « Figure vers laquelle l'enfant dirige son comportement d'attachement, donc toute personne s'engageant dans une interaction sociale durable et animée avec le bébé, répondant facilement à ses signaux et ses approches. »
Caregiver	Personne qui prend soin et peut répondre aux besoins de protection et de réconfort.

Terme	Définition
Caregiving	Système de conduites de protection et de réconfort complémentaire du système d'attachement. Extrait du support, p. 17 : « Cette réponse aux besoins d'attachement de l'enfant peut s'organiser en système réciproque (ou complémentaire) du système d'attachement de l'enfant : il s'agit du caregiving (fonction de prendre soin, souvent dévolue aux parents mais pas uniquement). Le caregiver cherche à rétablir ou maintenir la proximité physique et psychologique avec le bébé quand il est en situation de danger ou de détresse afin de répondre à ses besoins et de le protéger. Le caregiving est associé chez le caregiver à des émotions spécifiques : plaisir/satisfaction/soulagement quand il peut protéger l'enfant, colère/tristesse/anxiété quand il ne le peut pas. »
Sensibilité relationnelle	Capacité à percevoir et interpréter les signaux de l'autre et ses besoins dans la relation.
Responsivité	Capacité à répondre de façon ajustée aux signaux et aux besoins perçus.
Base de sécurité	Confiance dans la disponibilité d'une figure permettant de rechercher du réconfort et de s'engager dans l'exploration. Extrait du support, p. 17 : « la confiance dans l'idée qu'une figure protectrice sera accessible/disponible, quel que soit l'âge de l'individu »
Angoisse de séparation	Détresse liée à l'absence ou à la perte redoutée d'une figure importante ; son interprétation dépend de l'âge, du contexte, de l'intensité et du retentissement.
MIO	Modèles internes opérants : représentations de soi, d'autrui et des interactions qui orientent les attentes et les conduites relationnelles.
Partenariat corrigé quant au but	Organisation de la relation dans laquelle l'enfant prend progressivement en compte les intentions de l'autre pour ajuster les moyens de maintenir le lien.
Système exploratoire	Organisation des conduites de découverte et de maîtrise de l'environnement, facilitée par un sentiment suffisant de sécurité.
Système affiliatif	Conduites orientées vers les relations avec les autres et l'appartenance sociale, notamment avec les pairs.
Carence affective	Insuffisance durable de relations et de réponses affectives ajustées aux besoins, susceptible de compromettre le développement.
Éthologie	Étude des comportements animaux dans leurs conditions de vie, en milieu naturel ou dans des dispositifs d'observation.
Empreinte	Apprentissage précoce, décrit chez certaines espèces, orientant une conduite vers un objet rencontré dans une période sensible ; ne se superpose pas directement à l'attachement humain.
Dépression anaclitique	Description historique de Spitz d'un tableau de détresse et de retrait du nourrisson après la perte d'une relation auparavant investie.

Terme	Définition
Hospitalisme	Tableau historique de perturbations graves du développement et de la relation lié à une privation relationnelle prolongée dans un environnement institutionnel défaillant.
Retrait relationnel	Diminution importante de l'engagement dans les échanges ; signe à explorer, sans cause unique déduite de sa seule présence.
Stéréotypie	Répétition de mouvements ou de conduites relativement semblables ; sa signification dépend de l'ensemble du fonctionnement et du contexte.
Protestation / désespoir / détachement	Trois phases possibles décrites par les Robertson lors de séparations prolongées : tentative active de retrouver le lien, retrait, puis diminution apparente des manifestations d'attachement.
Holding	Chez Winnicott, portage et contenance physiques et psychiques dans un environnement suffisamment fiable.
Handling	Chez Winnicott, manière de manipuler le bébé et de prodiguer les soins corporels, en s'ajustant à ses rythmes et réactions.
Object-presenting	Chez Winnicott, présentation ajustée des objets et ouverture progressive au monde extérieur.
Psyché-soma	Articulation de la vie psychique et de l'expérience corporelle ; dans le modèle, sentiment d'habiter son corps.
Self	Chez Winnicott, expérience subjective d'être soi et de continuité d'existence, soutenue par l'environnement précoce.
Objet transitionnel	Objet investi dans une aire intermédiaire entre vécu subjectif et réalité extérieure, pouvant soutenir la tolérance de l'absence.
Phénomène transitionnel	Expérience, rituel ou activité occupant cette aire intermédiaire ; ne se limite pas à un objet matériel.
Situation étrange	Procédure standardisée d'Ainsworth observant le jeune enfant avec une figure d'attachement lors de brefs épisodes de présence, séparation et retrouvailles.
Attachement sécure	Organisation dans laquelle la figure peut être utilisée pour se réconforter et retrouver une disponibilité à l'exploration.
Attachement insécure évitant	Organisation marquée par la limitation visible de la recherche de proximité et l'évitement du contact, notamment aux retrouvailles.
Attachement insécure ambivalent / résistant	Organisation associant forte détresse, recherche de contact et résistance au réconfort lors des retrouvailles.
Attachement désorganisé	Conduites contradictoires, figées ou interrompues à certains moments d'activation du lien, sans stratégie cohérente disponible.

Terme	Définition
Sociabilité indiscriminée	Approche sociale insuffisamment différenciée des adultes, parfois excessivement familière, avec peu de vérification auprès d'une figure repère.
Alliance de caregiving	Coopération entre les adultes qui prennent soin pour préserver protection, continuité et sécurité malgré d'éventuels désaccords.
Émotion	Réaction généralement brève à une situation significative, associant vécu subjectif, évaluation cognitive et modifications corporelles. Extrait du support, p. 17 : « Réaction survenant le plus souvent brusquement et pour une durée relativement brève à l'apparition d'une situation significative pour le sujet. Réaction qui est à la fois cognitive (processus cognitifs) et à la fois biologique. »
Régulation émotionnelle	Processus par lesquels l'intensité, la durée et l'expression d'une émotion sont modulées, avec l'aide d'autrui ou par le sujet.
Fonction sémiotique	Capacité d'évoquer des objets, personnes ou événements au moyen de signes et de symboles, notamment en leur absence.
Jeu symbolique	Activité de faire-semblant où un objet, un geste ou un rôle représente autre chose que sa réalité immédiate.
Image mentale	Représentation interne d'un objet ou d'une situation en l'absence de perception directe.
Réalisme fortuit	Dans le développement du dessin, attribution après coup d'une signification à une production initialement non prévue pour la représenter.
Réalisme intellectuel	Mode de dessin montrant ce que l'enfant sait d'un objet plutôt que seulement ce qu'il en voit depuis un point de vue.
Sous-extension	Utilisation d'un mot pour une partie trop restreinte de la catégorie qu'il désigne.
Sur-extension	Utilisation d'un mot pour une catégorie trop large par rapport à son sens partagé.
Pragmatique du langage	Usage du langage dans une situation de communication, selon le but, l'interlocuteur et le contexte.
Capacité métasyntaxique	Capacité à réfléchir sur les règles d'organisation grammaticale des phrases.
Voie phonologique / assemblage	Traitement de l'écrit reposant sur les correspondances entre unités écrites et unités sonores.
Voie lexicale / orthographique	Identification de mots écrits connus à partir de représentations orthographiques mémorisées.
Dyslexie	Trouble durable de l'apprentissage de la lecture, qui demande une évaluation spécialisée et ne se réduit pas à un test isolé.
Dysorthographie	Trouble durable de l'acquisition et de l'utilisation de l'orthographe.

Terme	Définition
Dyscalculie	Trouble durable des apprentissages numériques et du calcul, à apprécier dans une évaluation globale.
Trouble du langage oral	Difficultés persistantes de compréhension ou d'expression orales avec retentissement ; l'ancienne appellation « dysphasie » est évoquée dans le cours.
Résignation apprise	Attente que ses actions ne modifieront plus les résultats, pouvant se construire lors d'expériences répétées d'impuissance ou d'échec.
Égocentrisme cognitif	Difficulté à distinguer et coordonner son point de vue avec celui d'autrui, dans le modèle piagétien.
Décentration	Capacité à considérer plusieurs dimensions ou points de vue au lieu de rester centré sur un seul.
Animisme	Attribution de vie ou d'intentions à des objets ou phénomènes, dans la description piagétienne de la pensée enfantine.
Artificialisme	Idée que les phénomènes et les choses sont fabriqués par l'homme, dans le modèle présenté.
Réalisme enfantin	Tendance à traiter des phénomènes mentaux, comme les rêves, comme s'ils possédaient une réalité matérielle extérieure.
Réversibilité logique	Capacité à concevoir mentalement l'annulation ou la compensation d'une transformation.
Conservation	Compréhension qu'une propriété demeure identique malgré une transformation d'apparence qui ne la modifie pas.
Opérations infralogiques	Opérations structurant les propriétés et les relations internes des objets, notamment leurs aspects spatiaux et physiques, chez Piaget.
Opérations logico-mathématiques	Opérations structurant les rapports entre objets ou classes : classification, inclusion, ordre et nombre.
Classification / inclusion	Organisation en classes et sous-classes, avec compréhension de l'appartenance d'une partie à un ensemble plus vaste.
Sériation	Mise en ordre d'éléments selon une relation, par exemple du plus petit au plus grand.
Transitivité	Possibilité de déduire une relation à partir de deux autres : si A > B et B > C, alors A > C.
Théorie de l'esprit	Capacité à attribuer des états mentaux à soi-même et à autrui pour comprendre et anticiper les conduites.
Fausse croyance	Représentation tenue pour vraie par une personne alors qu'elle ne correspond pas à la réalité connue de l'observateur.

Terme	Définition
Croyance du second ordre	Représentation de ce qu'une personne croit concernant l'état mental d'une autre : « il croit qu'elle pense que… ».
Contagion émotionnelle	Résonance affective dans laquelle l'émotion exprimée par autrui déclenche une réaction émotionnelle, sans supposer à elle seule une prise de perspective élaborée.
Empathie	Capacité à comprendre ou partager certains aspects de l'expérience affective d'autrui en conservant une distinction entre soi et l'autre.
Cognition sociale	Ensemble des processus permettant de percevoir, comprendre et interpréter les informations et relations sociales.
Socialisation	Processus d'apprentissage et d'appropriation des normes, valeurs, rôles et pratiques permettant la participation à la vie sociale.
Hétéronomie	Situation dans laquelle la règle est reçue d'une autorité extérieure au sujet.
Autonomie	Capacité progressive à se déterminer et à s'approprier les règles, compatible avec le recours à des soutiens.
Adolescence	Période de remaniements corporels, affectifs, cognitifs et sociaux liée notamment aux transformations pubertaires et au passage vers des rôles adultes.
Puberté	Transformations biologiques conduisant à la maturation sexuelle et reproductive, distinctes de la maturité psychique et légale.
Image du corps	Ensemble des représentations et vécus subjectifs concernant son propre corps.
Identité	Sentiment d'être soi, singulier et suffisamment cohérent à travers le temps et les changements, en relation avec autrui et les appartenances.
Moratoire identitaire	Dans le modèle de Marcia, exploration active de possibilités identitaires sans engagements encore stabilisés.
Pensée hypothético-déductive	Raisonnement qui pose des hypothèses, en déduit des conséquences et peut les confronter aux faits.
Combinatoire	Exploration organisée de différentes combinaisons possibles d'éléments ou de propositions.
Logique des propositions	Étude des relations entre énoncés au moyen d'opérateurs comme négation, conjonction ou implication.
INRC	Groupe de transformations piagétien : Identité, Négation, Réciproque et Corrélative ; articulation de transformations réversibles.
Introspection	Examen de ses propres pensées, sentiments et expériences internes.
Argumentation	Organisation de raisons destinées à soutenir ou discuter une proposition, en tenant compte des objections et de l'interlocuteur.

Terme	Définition
Illettrisme	Maîtrise insuffisante de l'écrit dans les situations ordinaires chez une personne qui a été scolarisée.
Analphabétisme	Absence d'apprentissage initial de la lecture et de l'écriture.
Allophonie	Situation d'une personne dont la langue première est différente de celle du milieu considéré ; ce n'est pas un trouble.
Dilemme moral	Situation dans laquelle plusieurs exigences ou valeurs entrent en conflit et rendent la décision problématique.
Morale préconventionnelle	Dans le modèle de Kohlberg, raisonnement centré sur la punition, la récompense et l'intérêt individuel.
Morale conventionnelle	Dans le modèle de Kohlberg, raisonnement fondé sur les attentes des groupes, les règles et l'ordre social.
Morale postconventionnelle	Dans le modèle de Kohlberg, examen des règles selon des droits, un contrat social ou des principes éthiques universalisables.
Estime de soi	Évaluation affective que le sujet porte sur lui-même et sur sa valeur.
Sentiment d'efficacité personnelle	Croyance en sa capacité à organiser et réaliser les actions requises dans une situation.
Lieu de contrôle interne	Tendance à attribuer les résultats aux actions ou capacités du sujet plutôt qu'aux seules forces extérieures.
Autonomie comportementale	Possibilité de prendre certaines décisions et de réaliser des actions sans autorisation parentale à chaque occasion.
Clique / bande	Dans le modèle présenté, petit groupe de proches puis groupe plus large de pairs ; descriptions de sociabilité et non étapes obligatoires.
Refus scolaire anxieux	Difficulté à fréquenter l'école liée à une détresse anxieuse, dont les mécanismes et le contexte doivent être explorés.
Narcissisme	Dans le sens psychanalytique du cours, investissement du Moi et de l'image de soi, distinct d'un jugement courant d'égoïsme.
Finitude	Condition d'un être dont l'existence est limitée et mortelle.
Deuil	Ensemble des réactions et du remaniement psychique consécutifs à une perte significative ; son évolution varie et ne suit pas une séquence obligatoire.
Régression	Recours à des modes de fonctionnement ou de relation antérieurs face à une difficulté, dans la lecture psychodynamique.
Déni	Refus inconscient de reconnaître un aspect de réalité vécu comme trop éprouvant, dans le modèle psychanalytique.

Terme	Définition
Dénégation	Expression d'un contenu de pensée accompagnée du refus de le reconnaître comme sien.
Mémoire	Ensemble des capacités d'encodage, de conservation et de récupération des informations et connaissances. Extrait du support, p. 34 : « La mémoire est la capacité du cerveau d'enregistrer, de stocker et de récupérer des connaissances acquises »
Encodage / stockage / récupération	Traitement initial de l'information / maintien de traces / accès ultérieur à l'information mémorisée.
Mémoire sensorielle	Maintien très bref d'informations sensorielles, dont la durée dépend de la modalité.
Mémoire à court terme	Maintien temporaire d'une quantité limitée d'informations.
Mémoire de travail	Maintien et manipulation d'informations nécessaires à une activité en cours.
Mémoire à long terme	Conservation durable de connaissances et d'expériences, selon plusieurs systèmes.
Mémoire déclarative	Mémoire de contenus accessibles à un rappel conscient, comprenant notamment les mémoires épisodique et sémantique. Extrait du support, p. 34 : « Mémoire qui correspond au rappel conscient et volontaire de connaissances anciennes »
Mémoire épisodique	Mémoire d'événements personnellement vécus et situés dans un contexte temporel et spatial. Extrait du support, p. 34 : « regroupe des représentations d'événements temporellement datées (événements ou épisodes personnellement vécus) »
Mémoire sémantique	Mémoire des connaissances générales, du sens des mots et des concepts. Extrait du support, p. 34 : « regroupe les connaissances générales nécessaires à la production et la compréhension linguistique (mots, symboles verbaux, significations, référents, etc.) »
Mémoire non déclarative	Ensemble de formes de mémoire s'exprimant sans rappel conscient nécessaire, dont la mémoire procédurale. Extrait du support, p. 34 : « Mémoire qui correspond à la répercussion inconsciente d'expériences anciennes »
Mémoire procédurale	Mémoire des habiletés et savoir-faire progressivement automatisés.
Rappel / reconnaissance	Retrouver une information sans qu'elle soit présentée / identifier une information parmi des éléments proposés.
Intelligence fluide	Capacités de raisonnement et de résolution de problèmes nouveaux, relativement indépendantes des connaissances apprises.
Intelligence cristallisée	Capacités s'appuyant sur les connaissances et l'expérience accumulées.

Terme	Définition
Plainte mnésique	Difficulté de mémoire rapportée par la personne, qui ne suffit pas à établir une pathologie.
Anosognosie	Méconnaissance par la personne de ses troubles, liée à son fonctionnement pathologique, distincte d'un simple refus volontaire.
Trouble neurocognitif majeur	Déclin acquis significatif d'un ou plusieurs domaines cognitifs compromettant l'autonomie ; la mémoire n'est pas nécessairement atteinte en premier.
Dépression	Trouble associant notamment une humeur dépressive ou une perte d'intérêt durable, avec d'autres manifestations et un retentissement ; elle ne se réduit pas à une tristesse ponctuelle.
Apraxie	Trouble de la réalisation de gestes appris, non expliqué par une simple faiblesse motrice ou une incompréhension de la consigne.
Aidant	Personne de l'entourage apportant une aide régulière à un proche dans sa vie quotidienne ou ses soins.
Infantilisation	Manière de traiter un adulte comme un enfant, en négligeant sa dignité, ses choix ou ses capacités préservées.
Relation d'attachement chez l'adulte et réciprocité	Chez l'adulte, une relation d'attachement peut fournir une base de sécurité réciproque : chacun peut donner et recevoir soutien et attention. Le partenaire est investi comme une personne singulière, non interchangeable, dont la proximité est recherchée. Le recours à cette base s'appuie notamment sur les échanges verbaux et les représentations du lien. Extrait du support, p. 33 : « lien affectif durable au sein duquel le partenaire est conçu comme unique, non interchangeable et dont on désire la proximité »
Style d'attachement chez l'adulte	Organisation relativement systématisée des attentes, besoins, émotions, stratégies de régulation et comportements sociaux dans les relations d'attachement. Elle se construit à partir des expériences relationnelles et influence la manière d'attendre ou de rechercher la disponibilité et le soutien d'autrui. Extrait du support, p. 33 : « patterns systématisés d'attentes/besoins/émotions/stratégies de régulation émotionnelle/comportements sociaux »
Attachement symbolique chez le sujet âgé	Appui sur les représentations et les souvenirs des liens d'attachement pour trouver du soutien et du réconfort, notamment lorsque les figures d'attachement ne sont plus présentes. Les objets familiers, les photographies et les lieux peuvent contribuer au maintien de repères liés à l'histoire et aux relations de la personne. Extrait du support, p. 33 : « l'évocation des souvenirs suffit à apporter soutien et réconfort »
Attachement chez le sujet âgé	Les besoins d'attachement persistent au cours du vieillissement. La vulnérabilité, la dépendance et les situations de détresse peuvent les réactiver. Le conjoint, la fratrie, les amis et les enfants adultes peuvent être des figures importantes ; les pertes et les séparations modifient les appuis disponibles.

Terme	Définition
Attachement et troubles neurocognitifs	Les besoins d'attachement et la fonction de réconfort du lien peuvent persister malgré la détérioration cognitive. Une relation régulière et des repères familiers peuvent soutenir le sentiment de sécurité, même lorsque la personne confond l'identité de celui qui s'occupe d'elle.
Besoin primaire de proximité	Dans la théorie de l'attachement présentée dans le cours, le jeune enfant recherche la proximité d'une figure familière pour obtenir protection, sécurité et réconfort. Le lien d'attachement ne se réduit pas à la satisfaction de la faim.
Besoin primaire de contact	Besoin de contact physique, tactile et thermique pouvant procurer du réconfort. Dans les expériences de Harlow présentées dans le cours, le contact avec un support doux ne se confond pas avec la seule délivrance de nourriture.
Proximité dans l'attachement	Maintien ou recherche d'un accès à la figure d'attachement, particulièrement en situation de détresse. Ses modalités évoluent : contact et présence physique chez le jeune enfant, mais aussi échanges et représentations du lien plus tard. Extrait du support, p. 17 : « notion spatiale, distance entre l'enfant et la figure d'attachement qui peut être modulée en fonction des besoins de l'enfant »
Norme idéale	Repère de normalité fondé sur un état jugé souhaitable ou valorisé ; il ne se confond pas avec ce qui est fréquent ni avec l'absence de maladie.
Normalité comme absence de maladie	Lecture du normal définie par l'absence de maladie identifiée, distincte des lectures statistique, sociale et idéale.
Prévalence	Nombre de cas existants d'une maladie dans une population à un moment donné ou sur une période déterminée ; exprimée en proportion, elle rapporte ces cas à la population considérée.
Incidence	Survenue de nouveaux cas d'une maladie dans une population pendant une période définie ; elle se distingue de la prévalence des cas existants.
Étiologie	Étude des causes et facteurs à l'origine d'une maladie.
Pathogénie	Étude des mécanismes par lesquels une maladie apparaît et se développe.
Lecture professionnelle du pathologique	Dans la typologie du cours, désignation d'un état comme pathologique par un professionnel, notamment médecin ou psychologue.
Lecture existentialiste du pathologique	Dans la typologie du support, approche mettant l'accent sur la modification de l'environnement plutôt que sur celle de l'individu.
Critères pratiques du pathologique	Trois critères cités dans le support : inconfort, bizarrerie et inefficacité. Leur appréciation est contextuelle ; aucun signe isolé ne suffit à établir une pathologie.
Style éducatif contractualiste	Style décrit dans le cours comme démocratique : règles présentes, expliquées et discutables, avec une place à la compréhension et à la négociation. Le support nomme les parents « contractualisés ».
Style éducatif statutaire	Style décrit dans le cours comme autoritaire, fondé sur la position et l'autorité de l'adulte, laissant moins de place à la discussion des règles.

Terme	Définition
Style éducatif maternaliste	Style décrit comme protecteur et chaleureux, valorisant la cohésion familiale, avec une marge de décision de l'enfant plus limitée.
Famille bastion	Type de cohésion familiale évoqué dans le cours, privilégiant le collectif, l'unité et les activités communes. Il s'agit d'un repère descriptif et non d'un diagnostic familial.
Famille association	Type de cohésion familiale évoqué dans le cours, laissant davantage de place à l'individualisation et aux activités ou choix personnels. Ce repère ne suffit pas à caractériser une famille entière.
Construction opératoire du nombre	Dans le modèle piagétien présenté, articulation de l'inclusion des classes et de la relation d'ordre ; à distinguer de la récitation précoce de la suite des nombres.
Idéologie	Dans le chapitre de l'adolescence, raisonnement abstrait sur la politique, l'éducation ou la religion, prenant en compte l'évolution des idées et se référant à des principes généraux plutôt qu'à des opinions particulières.
Métatexte	Éléments qui accompagnent et organisent un texte, tels titres, notes ou indications, et contribuent à orienter sa lecture et sa compréhension.
Réciprocité de l'attachement adulte	Possibilité, au sein de la relation adulte, de fournir et de recevoir tour à tour soutien, attention et sécurité.
Continuité temporelle de l'identité	Sentiment de demeurer soi au fil du temps et des transformations, composante de la construction identitaire.
Cohésion et singularité identitaires	Sentiment d'être un sujet suffisamment unifié et cohérent, distinct des autres, malgré les remaniements et appartenances multiples.